

Bunga Rampai

PENDAMPINGAN PERSALINAN AMAN

Dan Berpusat Pada Perempuan

Syaflindawati • Ernita Prima Noviyani • Sulastris Handayani • Rahmi padlilah

Editor: Lolita Nugraeny



BUNGA RAMPAI PENDAMPINGAN PERSALINAN AMAN DAN BERPUSAT PADA PEREMPUAN

Penulis:

Syaflindawati, S.SiT., M.Keb.

Ernita Prima Noviyani, S.ST., Bdn., M.Kes.

Sulastri Handayani, S.Tr.Keb., Bdn., M.Keb.

Rahmi padlilah, SST., Bdn., M.Keb.

Editor:

Bd. Lolita Nugraeny, SST., M.Keb.



Bunga Rampai Pendampingan Persalinan Aman Dan Berpusat Pada Perempuan

Penulis:

Syaflindawati, S.SiT., M.Keb.

Ernita Prima Noviyani, S.ST., Bdn., M.Kes.

Sulastri Handayani, S.Tr.Keb., Bdn., M.Keb.

Rahmi padlilah, SST., Bdn., M.Keb.

Editor:

Bd. Lolita Nugraeny, SST., M.Keb.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7756-36-7

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2026

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya buku bunga rampai berjudul **“Pendampingan Persalinan Aman dan Berpusat pada Perempuan.”** Buku ini disusun sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, tenaga kesehatan, serta pemerhati kesehatan ibu dan anak dalam memahami pentingnya pendampingan persalinan yang aman, nyaman, bermartabat, dan berorientasi pada kebutuhan perempuan. Persalinan merupakan proses fisiologis yang membutuhkan pemantauan, dukungan, keterampilan klinis, serta pendekatan humanis agar ibu dapat menjalani proses kelahiran dengan rasa aman, dihargai, dan memperoleh pelayanan yang sesuai standar.

Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam pendampingan persalinan, dimulai dari konsep dasar persalinan normal dan aman, pengertian persalinan yang aman, proses persalinan normal yang berpusat pada perempuan, prinsip persalinan aman, serta konsep *Respectful Maternity Care* sebagai landasan pelayanan kebidanan yang menghargai hak, pilihan, dan martabat ibu. Pembahasan juga mencakup tindakan serta pemeriksaan yang tidak direkomendasikan pada kala II, sehingga pembaca dapat memahami pentingnya praktik kebidanan yang berbasis bukti, tidak berlebihan, dan tetap mengutamakan keselamatan ibu maupun bayi.

Selain itu, buku ini menguraikan pengkajian kebidanan selama proses persalinan, pemantauan kemajuan persalinan dan kesejahteraan ibu-janin, penggunaan partograf, deteksi dini komplikasi, serta pencegahan komplikasi persalinan. Materi-materi tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan bidan dalam melakukan pengkajian, pemantauan, pengambilan keputusan, dokumentasi, serta tindakan pencegahan secara tepat selama proses persalinan. Penulis berharap buku bunga rampai ini dapat menjadi sumber rujukan yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu pelayanan kebidanan, mendukung persalinan yang aman, serta mendorong praktik pelayanan yang lebih empatik, profesional, dan berpusat pada perempuan.

Editor

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
---------------------	------------

DAFTAR ISI.....	iv
------------------------	-----------

CHAPTER 1 KONSEP DASAR PERSALINAN NORMAL DAN AMAN..... 1

Syaflindawati, S. SiT., M.Keb.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Pengertian Persalinan Yang Aman.....	2
C. Proses Persalinan Normal Dan Berpusat Pada Perempuan.....	4
D. Prinsip Persalinan Aman	7
E. Konsep Persalinan Nyaman (Respectful Maternity Care)	8
F. Tindakan dan pemeriksaan yang tidak direkomendasikan pada kala II :	14
G. Simpulan.....	16
H. Referensi.....	17
I. Glosarium.....	18

CHAPTER 2 PENGKAJIAN KEBIDANAN SELAMA PROSES PERSALINAN..... 19

Ernita Prima Noviyani, S.ST., Bdn., M.Kes.	19
A. Pendahuluan.....	19
B. Konsep Dasar Pengkajian Persalinan	19
C. Komponen Pengkajian Kebidanan Selama Persalinan	20
D. Pengkajian Berdasarkan Kala Persalinan	28
E. Identifikasi Masalah dan Diagnosis Kebidanan.....	30
F. Dokumentasi Pengkajian.....	30
G. Peran Bidan dalam Pengkajian Persalinan	30
H. Kesimpulan	33
I. Referensi.....	33
J. Glosarium.....	35

CHAPTER 3 PEMANTAUAN KEMAJUAN PERSALINAN DAN KESEJAHTERAAN IBU JANIN..... 37

Sulastr Handayani, S.Tr.Keb., Bdn., M.Keb.	37
A. Pendahuluan.....	37
B. Konsep Dasar Pemantauan Persalinan	38
C. Parameter Pemantauan Ibu dan Janin	40

D. Pemantauan Kemajuan Persalinan dengan Partograf	44
E. Deteksi dini dan komplikasi	46
F. Simpulan.....	47
G. Referensi.....	48
H. Glosarium.....	49
CHAPTER 4 PENCEGAHAN KOMPLIKASI PERSALINAN.....	51
Rahmi padlilah, SSR., Bdn., M.Keb.	51
A. Pendahuluan.....	51
B. Konsep Dasar Komplikasi Persalinan	56
C. Referensi.....	70
PROFIL PENULIS	73

CHAPTER 1

KONSEP DASAR PERSALINAN NORMAL DAN AMAN

Syaflindawati, S. SiT., M.Keb.

A. Pendahuluan

Persalinan merupakan proses fisiologis yang sangat penting dalam kehidupan seorang perempuan. Selain menjadi proses kelahiran bayi, persalinan juga merupakan pengalaman emosional dan psikologis yang dapat memengaruhi kesehatan ibu secara menyeluruh. Oleh karena itu, pelayanan persalinan tidak hanya berfokus pada keselamatan ibu dan bayi, tetapi juga harus memperhatikan kenyamanan, martabat, kebutuhan, serta hak-hak perempuan selama proses persalinan berlangsung.

Persalinan normal dan aman menjadi tujuan utama dalam pelayanan kesehatan ibu, karena dapat mengurangi risiko komplikasi bagi ibu maupun bayi. Oleh karena itu, pemahaman tentang konsep persalinan normal dan aman sangat penting bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat.

Di berbagai negara, termasuk Indonesia, angka kematian ibu dan bayi masih menjadi perhatian utama dalam bidang kesehatan. Salah satu upaya untuk menurunkan angka tersebut adalah dengan memastikan bahwa setiap persalinan berlangsung secara normal dan aman. Persalinan yang aman melibatkan tenaga kesehatan terlatih, fasilitas yang memadai, serta pemantauan kondisi ibu dan janin secara tepat.

Pemahaman mengenai konsep persalinan normal dan aman sangat penting, tidak hanya bagi tenaga kesehatan, tetapi juga bagi masyarakat, khususnya ibu hamil. Dengan pengetahuan yang baik, diharapkan ibu dapat mempersiapkan diri secara optimal dalam menghadapi persalinan.

Pemantauan persalinan atau melahirkan, dan bagaimana melakukan identifikasi dini serta penatalaksanaan pengobatan komplikasi sangat penting untuk mencegah hasil kelahiran yang merugikan yakni kematian ibu dan anak.

Dalam upaya menurunkan AKI, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti masalah dalam akses, kualitas dan disparitas dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kualitas pelayanan dan rujukan merupakan tantangan besar dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir.

Penyediaan layanan yang komprehensif dan berkualitas akan menghadapi tantangan lebih besar lagi ketika jumlah penduduk yang dilayani semakin besar.

Tantangan dalam aspek manajemen program dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap ibu dan bayi baru lahir sangat besar dan perlu perhatian yang serius, mengingat adanya keterbatasan baik dari sumber daya manusia maupun penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kesehatan.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan terutama seputar masa persiapan kehamilan dan persiapan fase kelahiran terhadap ibu telah diidentifikasi sebagai strategi yang paling berdampak untuk menekan dan mengurangi angka kelahiran mati baik terhadap bayi baru lahir maupun kematian terhadap ibu. Oleh karena itu pelayanan dalam mengawasi proses persalinan yang aman dan nyaman harus menjadi garda terdepan bagi tenaga kesehatan khususnya bagi profesi bidan (WHO, 2020)

Konsep persalinan yang aman dan nyaman berpusat pada perempuan (*women centered care*) menempatkan perempuan sebagai pusat pelayanan. Dalam pendekatan ini, ibu dihargai sebagai individu yang memiliki hak untuk membuat keputusan, memperoleh informasi yang jelas, serta mendapatkan dukungan fisik dan emosional selama proses persalinan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan pengalaman melahirkan yang positif sekaligus meningkatkan keselamatan ibu dan bayi.

B. Pengertian Persalinan Yang Aman

Persalinan normal adalah proses keluarnya janin yang terjadi secara alami melalui jalan lahir (vagina) dengan presentasi belakang kepala, tanpa menggunakan alat bantu atau intervensi medis yang berlebihan. Persalinan ini biasanya berlangsung pada kehamilan cukup bulan (37–42 minggu), dengan kondisi ibu dan janin yang sehat.

Persalinan aman dan nyaman berpusat pada perempuan adalah pelayanan persalinan yang mengutamakan keselamatan ibu dan bayi dengan tetap menghormati kebutuhan, pilihan, nilai, budaya, dan kenyamanan perempuan selama proses persalinan.

Persalinan normal atau pervaginam adalah proses persalinan yang paling aman untuk ibu dan janin ketika janin cukup bulan pada usia kehamilan 37 hingga 42 minggu tanpa penyulit. Persalinan pervaginam lebih disukai mengingat morbiditas dan mortalitas yang terkait dengan kelahiran dengan cara operatif atau caesar telah meningkat dari waktu ke waktu. Sekitar 80% dari semua persalinan pervaginam terjadi cukup bulan melalui persalinan spontan, sedangkan 11% adalah prematur, dan 10% lewat bulan.

Persalinan normal merupakan proses fisiologis alami yang melibatkan interaksi kompleks antara ibu, janin, dan lingkungan. Proses ini tidak hanya sekedar keluarnya bayi dari rahim, tetapi juga melibatkan perubahan fisik, hormonal, dan psikologis.

Pengambilan keputusan dalam proses persalinan sangat penting dilakukan serta kolaborasi dengan berbagai tenaga kesehatan untuk memastikan terjadinya penyimpangan. Probabilitas sebuah persalinan pervaginam yang berhasil adalah salah satu faktor terpenting dalam pengambilan keputusan proses selama konseling prenatal para wanita ini.

Asuhan Kebidanan sesuai standar difokuskan pada kemahiran (profisiensi) bidan bukan sekedar mampu (*competent*). Peralatan dan perlengkapan hanyalah penunjang dalam pemberian layanan, fokus utama adalah menjamin keterampilan mahir bidan dipertahankan (*quality assurance*) melalui latihan-latihan (*exercise*) bagi peningkatan mutu layanan (*quality improvement*). Terutama asuhan stabilisasi bayi baru lahir termasuk kemungkinan penyulit.

Secara umum konsep dasar persalinan normal mencakup 5 faktor utama (5P), yaitu:

1. Power

Kekuatan /kontraksi yang mendorong persalinan, terdiri dari:

- a. Kontraksi uterus (his) yang efektif
- b. Tenaga mengejan dari ibu

2. Passenger

Yaitu kondisi janin yang dapat mempengaruhi jalan lahir meliputi:

- a. Ukuran dan berat janin
- b. Letak, posisi, dan presentasi janin
- c. Kondisi janin

3. Passage Jalan lahir terdiri dari:

- a. Panggul tulang
- b. Jaringan lunak (serviks, vagina, perineum)

4. Position

Posisi ibu selama persalinan dapat mempengaruhi kelancaran proses, misalnya posisi jongkok, miring, atau setengah duduk yang sering dianjurkan oleh tenaga kesehatan dan juga kebanyakan dipilih oleh ibu dalam proses persalinan karena dapat membantu mempercepat penurunan kepala janin.

5. Psychological

Kondisi mental ibu sangat berpengaruh besar terhadap proses persalinan karena rasa takut dan cemas dapat menghambat kontraksi uterus, sedangkan rasa tenang, nyaman dan percaya diri dapat memperlancar proses persalinan. Selain itu penolong persalinan juga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelancaran proses persalinan, oleh karena itu dibutuhkan penolong persalinan yang trampil dan profesional agar dapat membantu ibu dalam menghadapi proses kelahiran yang sehat dan aman.

C. Proses Persalinan Normal Dan Berpusat Pada Perempuan

Pendekatan ini menekankan bahwa perempuan memiliki hak:

1. Mendapatkan informasi yang jelas
2. Diperlakukan dengan hormat
3. Terlibat dalam pengambilan keputusan
4. Mendapat dukungan emosional
5. Memilih pendamping persalinan
6. Mendapat pelayanan tanpa diskriminasi

Pelayanan yang berpusat pada perempuan juga memperhatikan aspek fisik, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual ibu.

1. Prinsip Persalinan Berpusat pada Perempuan antara lain:

- a. Menghormati hak dan martabat perempuan

Setiap perempuan berhak mendapatkan pelayanan yang sopan, ramah, dan tanpa kekerasan verbal maupun fisik. Tenaga kesehatan harus menjaga privasi dan kerahasiaan ibu selama proses persalinan. Seperti Menjelaskan tindakan medis sebelum dilakukan

- 1) Meminta persetujuan ibu
- 2) Menjaga privasi saat pemeriksaan

2. Keselamatan Ibu dan Bayi

Keselamatan tetap menjadi prioritas utama dalam persalinan. Tenaga kesehatan harus melakukan pemantauan kondisi ibu dan janin secara berkala untuk mendeteksi komplikasi secara dini.

Upaya menjaga keselamatan Ibu dan Bayi meliputi:

- a. Pemeriksaan tanda vital ibu
- b. Pemantauan denyut jantung janin
- c. Pencegahan infeksi
- d. Penanganan komplikasi secara cepat
- e. Persiapan rujukan bila diperlukan

3. Dukungan Emosional Selama Persalinan

Dukungan emosional sangat membantu ibu merasa lebih tenang dan percaya diri. Kehadiran suami, keluarga, atau pendamping persalinan dapat mengurangi kecemasan dan rasa takut.

Bentuk dukungan emosional:

- a. Memberikan motivasi
- b. Menenangkan ibu
- c. Mendampingi selama kontraksi
- d. Membantu teknik pernapasan dan relaksasi

4. Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan

Perempuan harus dilibatkan dalam setiap keputusan terkait proses persalinan. Tenaga kesehatan perlu memberikan informasi yang lengkap dan mudah dipahami agar ibu dapat menentukan pilihan terbaik.

Misalnya:

- a. Pemilihan posisi persalinan
- b. Metode pengurangan nyeri
- c. Persetujuan tindakan medis tertentu

5. Kenyamanan Selama Persalinan

Lingkungan yang nyaman dapat membantu proses persalinan berlangsung lebih baik. Kenyamanan mencakup aspek fisik maupun psikologis.

Faktor-faktor yang mendukung kenyamanan ibu selama persalinan:

- a. Ruangan bersih dan tenang
- b. Pencahayaan yang baik
- c. Kebebasan bergerak
- d. Posisi persalinan yang nyaman
- e. Dukungan tenaga kesehatan yang ramah

6. Manfaat Persalinan Berpusat pada Perempuan

Pelayanan dengan menghormati hak perempuan dalam persalinan adalah pendekatan pelayanan kesehatan yang menempatkan perempuan sebagai pusat asuhan, menghargai martabat, pilihan, kebutuhan, dan hak-haknya selama kehamilan, persalinan, hingga masa nifas. Pendekatan ini sering disebut Respectful Maternity Care (RMC) atau pelayanan maternitas yang penuh hormat.

Pelayanan persalinan yang aman dan nyaman memberikan banyak manfaat, antara lain:

Bagi Ibu :

- a. Mengurangi kecemasan dan stres
- b. Mengurangi trauma persalinan
- c. Meningkatkan rasa percaya diri
- d. Membantu ibu merasa dihargai

Bagi Bayi :

- a. Mengurangi risiko komplikasi
- b. Mendukung proses kelahiran yang lebih baik
- c. Memperkuat ikatan awal ibu dan bayi

Bagi Pelayanan Kesehatan :

- a. Meningkatkan kepuasan ibu
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan
- c. Mengurangi tindakan medis yang tidak perlu

7. Peran Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam mewujudkan persalinan yang aman dan nyaman berpusat pada perempuan. Bidan dan dokter harus mampu memberikan pelayanan yang profesional sekaligus penuh empati.

Peran tenaga kesehatan meliputi:

- a. Memberikan edukasi kepada ibu
- b. Memantau kondisi ibu dan janin
- c. Memberikan dukungan emosional
- d. Menghormati pilihan ibu
- e. Menjamin keselamatan ibu dan bayi

8. Tantangan dalam Pelaksanaan

Meskipun konsep ini sangat penting, masih terdapat beberapa hambatan dalam penerapannya, seperti:

- a. Kurangnya tenaga kesehatan
- b. Fasilitas yang terbatas
- c. Kurangnya pemahaman tentang hak perempuan
- d. Tingginya intervensi medis yang tidak diperlukan
- e. Budaya patriarki dalam pengambilan keputusan

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat. Proses persalinan berlangsung melalui beberapa mekanisme fisiologis yang terkoordinasi:

a. Mekanisme Persalinan (Cardinal Movements)

Gerakan janin saat melewati jalan lahir meliputi:

- 1) Engagement (Masuknya kepala ke panggul)
- 2) Descent (Penurunan)
- 3) Flexion (Penekukan kepala)
- 4) Internal Rotation (Putaran dalam)
- 5) Extension (Ekstensi kepala saat lahir)
- 6) External Rotation (Putaran luar)
- 7) Expulsion (Pengeluaran seluruh tubuh bayi)

b. Perubahan Fisiologis pada Ibu

Selama persalinan terjadi:

- 1) Dilatasi dan penipisan serviks
- 2) Peningkatan kontraksi uterus
- 3) Peningkatan hormon oksitosin dan endorfin
- 4) Adaptasi sistem pernapasan dan sirkulasi

c. Peran Hormon

- 1) Oksitosin: berfungsi dalam merangsang kontraksi rahim
- 2) Prostaglandin: membantu dalam proses pematangan serviks
- 3) Endorfin: bisa membantu mengurangi rasa nyeri secara alami

D. Prinsip Persalinan Aman

Persalinan dikatakan aman apabila dapat meminimalkan risiko terhadap kesehatan ibu dan bayi. Adapun prinsip utamanya meliputi:

- a. Pemberian asuhan oleh tenaga kesehatan terlatih (bidan/dokter)
- b. Pemantauan dengan menggunakan partograf untuk menilai kemajuan persalinan
- c. Pencegahan infeksi melalui teknik bersih dan steril
- d. Manajemen aktif kala III untuk mencegah perdarahan
- e. Rujukan cepat jika terjadi komplikasi

Tanda bahaya yang harus diwaspadai:

- a. Perdarahan hebat
- b. Tekanan darah tinggi
- c. Persalinan lama

d. Denyut jantung janin tidak normal

E. Konsep Persalinan Nyaman (Respectful Maternity Care)

Persalinan nyaman adalah kondisi ketika ibu merasa lebih tenang, tidak terlalu takut, dan mendapat dukungan fisik maupun emosional selama proses melahirkan. Cara Menciptakan Persalinan Nyaman Bagi Ibu antara lain :

- **Dukungan emosional**

Kehadiran suami, keluarga, atau pendamping persalinan dapat membantu ibu merasa lebih tenang.

- **Komunikasi yang baik**

Tenaga kesehatan perlu memberikan informasi dan dukungan agar ibu memahami proses persalinan.

- **Posisi persalinan yang nyaman**

Ibu dapat memilih posisi seperti duduk, miring, jongkok, atau berjalan sesuai kenyamanan.

- **Teknik relaksasi dan pernapasan**

Latihan napas membantu mengurangi rasa nyeri dan kecemasan.

- **Lingkungan yang tenang**

Ruangan bersih, nyaman, dan privasi terjaga dapat meningkatkan kenyamanan ibu.

- **Pengurangan nyeri**

Dapat dilakukan secara alami seperti pijatan, musik, kompres hangat, atau dengan bantuan medis bila diperlukan.

Tujuan Persalinan Aman dan Nyaman

1. Menjaga keselamatan ibu dan bayi
2. Mengurangi risiko komplikasi
3. Mengurangi rasa takut dan stres ibu
4. Membantu proses persalinan berjalan lancar
5. Memberikan pengalaman melahirkan yang positif

Proses persalinan melalui beberapa tahapan yaitu: Kala I, kala II, Kala III dan kala IV

1. Kala I (Kala Pembukaan)

Kala I Persalinan menguraikan tentang proses dan asuhan yang diberikan selama kala I persalinan, serta menjelaskan tata cara memberikan asuhan sayang ibu, melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan menggunakan lembar observasi dan partograf untuk memantau kemajuan kala I.

Kala 1 persalinan ini dimulai (inpartu) sejak uterus berkontraksi dan menyebabkan perubahan pada serviks (membuka dan menipis) dan berakhir sampai pembukaan serviks mencapai 10 cm.

Kala 1 persalinan terdiri dari dua fase, yaitu fase laten dan fase aktif.

- a. Fase Laten : periode waktu yang ditandai dengan kontraksi uterus yang teratur dan bervariasi yang berpengaruh terhadap perubahan serviks, termasuk beberapa derajat penipisan dan perkembangan dilatasi yang lebih lambat sampai 5 cm untuk persalinan pertama dan selanjutnya.
- b. Fase Aktif: periode waktu yang ditandai dengan kontraksi uterus yang teratur adekuat, terjadi penipisan serviks yang substansial dan dilatasi serviks yang lebih cepat dari 5 cm hingga penuh biasanya tidak melebihi 12 jam pada persalinan pertama, dan 10 jam pada persalinan selanjutnya (WHO, 2020).

Laju kemajuan pembukaan serviks minimal 1 cm/jam selama kala I fase aktif persalinan adalah tidak pasti untuk beberapa wanita. karena itu tidak dianjurkan untuk identifikasi normal kemajuan persalinan. Persalinan mungkin tidak berakselerasi secara alami sampai ambang pembukaan serviks 5 cm tercapai. Karena itu penggunaan intervensi medis untuk mempercepat persalinan dan kelahiran (seperti augmentasi oksitosin atau operasi caesar) sebelum ambang batas ini tidak dianjurkan, yang penting dapat dipastikan kondisi janin dan ibu baik.

Beberapa pemeriksaan lain yang direkomendasikan WHO dalam kala I:

- a. Pemeriksaan dalam dengan interval empat jam direkomendasikan untuk penilaian rutin fase aktif persalinan pada wanita berisiko rendah. Pemeriksaan vagina lebih sering dari pada setiap empat jam meningkatkan risiko infeksi bagi ibu dan bayi
- b. Penilaian kondisi janin secara teratur selama persalinan, dengan mendengarkan denyut jantung janin, merupakan bagian penting untuk memberikan kualitas asuhan intrapartum. Auskultasi denyut jantung janin secara intermiten dengan atau stetoskop Pinard direkomendasikan untuk wanita hamil yang sehat dalam persalinan.

Pada kala I persalinan fase aktif, mendengarkan denyut jantung biasanya dilakukan setiap 15-30 menit , sedangkan pada kala II biasanya dilakukan setiap 5 menit.

Durasi: Setiap auskultasi harus berlangsung setidaknya selama 1 menit; jika DJJ tidak dalam rentang normal (yaitu 110-160 bpm), auskultasi harus diperpanjang untuk mencakup setidaknya tiga kali kontraksi uterus.

Waktu: Auskultasi selama kontraksi uterus dan lanjutkan setidaknya selama 30 detik setelah kontraksi.

- c. Teknik relaksasi (non farmakologis) seperti relaksasi otot progresif, pernapasan, musik, perhatian dan teknik lainnya direkomendasikan untuk wanita hamil sehat yang meminta pereda nyeri selama persalinan. Teknik manual, seperti pijatan atau aplikasi kompres hangat, direkomendasikan untuk wanita hamil sehat yang meminta pereda nyeri selama persalinan.
- d. Untuk wanita dengan risiko rendah, cairan oral dan asupan makanan selama persalinan direkomendasikan
- e. Menganjurkan mobilitas dan posisi tegak selama persalinan pada wanita berisiko rendah dianjurkan.
- f. Manajemen nyeri

Pilihan penghilang rasa sakit non-farmakologis dapat bervariasi seperti: seperti air perendaman, hypnobirthing, akupunktur dan praktik budaya dan tradisional yang mungkin dapat mengurangi nyeri pada pasien. Kebanyakan wanita menginginkan beberapa bentuk penghilang rasa sakit selama persalinan, dan bukti kualitatif menunjukkan bahwa teknik relaksasi dapat mengurangi ketidaknyamanan persalinan, menghilangkan rasa sakit dan meningkatkan pengalaman persalinan yang menyenangkan bagi ibu. Teknik manual, termasuk massage atau kompres hangat serta rebozo, direkomendasikan untuk ibu.

Tindakan yang tidak direkomendasikan pada kala I:

- a. Pencukuran rambut pubis

Pencukuran rambut pubis tidak direkomendasikan pada persalinan pervaginam keputusan mengenai pencukuran perineum/pubis harus diserahkan kepada pasien itu sendiri. Dalam situasi di mana seorang wanita memilih untuk mencukur perineum/pubis sebelum melahirkan, dia harus disarankan untuk mencukur dirumah sesaat sebelum waktu persalinan dan melahirkan.

- b. Enema pada persalinan

Penggunaan enema untuk augmentasi persalinan secara rutin tidak terbukti mempercepat persalinan atau memberikan manfaat klinis lainnya. Ini dianggap invasif dan terkait dengan ketidaknyamanan untuk wanita.

- c. Cardiotokografi pada persalinan

Penggunaan CTG rutin untuk menilai kesejahteraan janin tidak direkomendasikan. Penggunaan CTG yang berkesinambungan dapat membatasi pergerakan ibu dan mobilisasi.

- d. Vagina Hygiene

Pembersihan vagina rutin dengan klorheksidin selama persalinan untuk tujuan mencegah infeksi morbiditas tidak dianjurkan

e. Cairan intravena untuk mencegah keterlambatan lamanya persalinan

Penggunaan cairan intravena dengan tujuan memperpendek lamanya persalinan tidak dianjurkan. WHO setuju bahwa wanita berisiko rendah harus dianjurkan untuk memberikan minum selama persalinan. WHO menekankan bahwa pada penggunaan cairan intravena untuk semua wanita dalam persalinan dapat meningkatkan biaya, berdampak besar pada penggunaan sumber daya dan mengurangi mobilitas perempuan.

2. Kala II Persalinan Normal

Kala II adalah periode waktu antara pembukaan serviks penuh dan kelahiran bayi, di mana wanita memiliki dorongan yang tidak disengaja untuk mengejan, sebagai akibat dari rahim ekspulsif kontraksi. Wanita harus diberitahu bahwa durasi kala II bervariasi dari satu wanita ke lain. Pada persalinan pertama, kelahiran biasanya selesai dalam waktu 3 jam sedangkan pada persalinan berikutnya, kelahiran biasanya selesai dalam waktu 2 jam.

Tindakan dan pemeriksaan yang direkomendasikan pada kala II persalinan diantaranya :

a. Pengaturan posisi saat melahirkan

Pengaturan posisi saat melahirkan yang bermanfaat untuk mempercepat kemajuan persalinan, mengurangi rasa sakit ibu, dan mengurangi trauma perineum.

Beberapa posisi melahirkan yang dianjurkan antara lain :

1) Posisi litotomi

Pada posisi litotomi, ibu berbaring telentang, kakinya tidak ditekuk dengan telapak kaki rata di permukaan kasur atau lantai, diletakkan di sanggurdi, penyangga kaki lurus atau dipegang oleh penolong. Posisi litotomi menawarkan kenyamanan bagi bidan dan dokter kandungan untuk memantau perkembangan persalinan dan menerapkan manuver bila diperlukan.

2) Posisi terlentang

Ibu berbaring telentang atau punggung sedikit terangkat (< 45 ke horizontal), kakinya lurus atau ditekuk dengan kaki berada di tempat tidur, di sandaran kaki, atau ditarik ke atas dan ke belakang ke arah bahunya. Bukti ilmiah terhadap penggunaan posisi terlentang menunjukkan bahwa posisi terlentang adalah posisi yang paling umum yang digunakan oleh ibu saat melahirkan di seluruh dunia

3) Posisi lateral (posisi berbaring miring)

Posisi lateral, yang juga disebut posisi berbaring miring, termasuk posisi Sims. Ibu berbaring miring dengan kedua pinggul dan lutut tertekuk dan diletakkan bantal di antara kedua kakinya, atau dengan kaki bagian atasnya terangkat dan ditopang. Posisi lateral ini mudah dilakukan dan nyaman.

4) Posisi duduk

Posisi duduk meliputi setengah duduk dan duduk sempurna. Pada posisi setengah duduk, ibu duduk dengan tulang belakang berada pada sudut > 45 derajat dari tempat tidur. Dalam posisi duduk murni, ibu duduk di tempat tidur, kursi, atau alat (Simkin P, 2017).

5) Posisi berlutut

Posisi berlutut dapat bervariasi dari berlutut tegak hingga merangkak. Umumnya posisi merangkak juga disebut posisi tangan dan lutut. Dalam posisi ini, ibu berlutut mencondongkan tubuh kedepan, menopang dirinya sendiri di kedua telapak tangan atau tinjunya.

6) Posisi jongkok

Dalam posisi jongkok, berat badan ibu sebagian besar bertumpu pada kakinya, tetapi lututnya sangat tertekuk, dan bersandar atau menarik badan. Posisi jongkok sering dianggap sebagai posisi paling alami, yang sangat mirip dengan kebiasaan posisi istirahat simpanse. Namun, kelemahan utama dari posisi jongkok adalah kesulitan bagi ibu hamil untuk mempertahankan jongkok untuk waktu yang lama. Dengan demikian, munculnya alat pendukung dapat memecahkan masalah itu.

b. Meneran

Menggunakan teknik Lamaze Breathing Keuntungan :

- 1) Meningkatkan angka persalinan alamiah, relaksasi pada otot memungkinkan oksigen yang cukup memasuki rahim dan memastikan persalinan berjalan lancar.
- 2) Pengurangan tingkat nyeri, lama persalinan dan perdarahan pasca persalinan ketika nyeri persalinan datang (kontraksi), bidan memimpin parturient untuk meredakan ketegangan otot dengan cara lamaze breathing yang menurunkan kadar 5-hydroxytryptamine dan akhirnya mengurangi rasa sakit.

c. Pijat perineum

Teknik untuk mencegah trauma perineum pada kala dua persalinan dan memfasilitasi kelahiran spontan termasuk pijat perineum, kompres hangat dan pelindung perineum dianjurkan. Bukti menunjukkan bahwa pijat perineum dapat meningkatkan kemungkinan menjaga perineum tetap utuh dan mengurangi risiko robekan perineum yang serius, bahwa kompres hangat perineum mengurangi robekan perineum derajat tiga dan empat, dan bahwa pendekatan "hands-on" (menjaga) mungkin mengurangi derajat robekan perineum. Sebagian besar wanita menerima teknik pencegahan perineum ini dan sangat mempengaruhi hasilnya.

d. Penyuntikan oksitosin (IM)

Oksitosin adalah obat pilihan dalam pencegahan HPP selama kala III persalinan dan memainkan peran sentral dalam manajemen HPP. Oksitosin tersedia di sebagian besar rumah sakit umum dan semua rumah sakit swasta. Oksitosin (10 IU, IM/IV) adalah obat uterotonik yang direkomendasikan untuk pencegahan HPP.

e. Hematologi bayi

Penundaan penjepitan dan pemotongan tali pusat bayi akan mempengaruhi:

1) Keuntungan penundaan penjepitan dan pemotongan tali pusat pada hemoglobin bayi saat lahir atau pada durasi tindak lanjut yang berbeda, menunjukkan pengurangan anemia tanpa efek samping yang tidak membahayakan. Ceriani dkk menemukan bahwa penundaan penjepitan dan pemotongan tali pusat bayi baru lahir cukup bulan pada 1 atau 3 menit terjadi peningkatan kadar hematokrit vena diukur pada 6 jam setelah lahir dalam kisaran fisiologis dan menurun prevalensi anemia neonatal.

2) Neurobehavior bayi

Kekurangan zat besi pada bayi akan mengganggu perkembangan saraf. Penundaan 30-60 detik dalam penjepitan tali pusat bermanfaat dalam meningkatkan neurobehavioral pada bayi premature (gestasi 34-36 minggu), yang menunjukkan skor yang lebih tinggi pada perkembangan motorik (MDV). Meskipun penundaan penjepitan dan pemotongan tali pusat meningkatkan status hematologi pada periode bayi baru lahir dan status zat besi pada usia 4 bulan, namun tidak mempengaruhi status zat

besi atau perkembangan saraf pada usia 12 bulan di populasi penelitian yang sama dari bayi lahir cukup bulan yang sehat.

3) Tekanan darah pada bayi

Tekanan darah rata-rata yang lebih tinggi dapat berkontribusi peningkatan hemodinamik dan perfusi organ pada bayi baru lahir, transfusi plasenta yang efektif dan volume darah ekstra dari penundaan penjepitan dan pemotongan tali pusat.

4) Sistem imun bayi

Darah pada tali pusat juga mengandung berbagai sel punca yang memainkan peran penting dalam memperbaiki jaringan dan imunokompeten. Penjepitan dan pemotongan tali pusat mengakibatkan transfusi meningkatkan stabilitas hemodinamik, sehingga mengurangi kerentanan bayi terhadap proses inflamasi.

5) Suhu bayi

Beberapa penelitian menemukan bahwa prosedur penundaan penjepitan dan pemotongan tali pusat ini dapat mempengaruhi kejadian hipotermia pada bayi prematur.

6) Pernapasan dan Apgar skor pada bayi

Untuk bayi prematur, karena sistem kardiopulmoner yang belum matang, transisi pernapasan dari janin ke neonatus pada kelahiran biasanya membutuhkan beberapa bantuan. Tindakan penundaan penjepitan dan pemotongan tali pusat sangat menguntungkan pada bayi yang membutuhkan resusitasi, reservoir penerima untuk darah plasenta melalui penurunan resistensi pembuluh darah paru. Penjepitan tali pusat yang tertunda menghasilkan volume darah yang lebih besar dan peningkatan sirkulasi paru dan curah jantung, memungkinkan pengiriman oksigen yang lebih besar ke jaringan dan penurunan kebutuhan untuk intervensi resusitasi.

F. Tindakan dan pemeriksaan yang tidak direkomendasikan pada kala II :

1. Amniotomi rutin

Penggunaan amniotomi untuk mempercepat persalinan tidak dianjurkan. Amniotomi untuk mempercepat persalinan secara klinis, tidak ada bukti yang jelas bahwa potensi manfaat lebih besar daripada potensi bahaya. Karena

amniotomi dini dapat meningkatkan risiko penularan HIV perinatal, di mana perempuan mungkin dengan status HIV yang tidak diketahui.

2. Episiotomi

WHO mengakui bahwa pada saat ini tidak ada bukti yang menguatkan perlunya episiotomi rutin dalam persalinan dan tingkat episiotomi yang “dapat diterima” sulit ditentukan. Peran episiotomi dalam kedaruratan obstetrik seperti gawat janin yang membutuhkan persalinan pervaginam masih harus ditetapkan.

3. Tekanan fundus

Penerapan tekanan pada fundus untuk memfasilitasi persalinan selama kala II persalinan tidak dianjurkan. WHO memiliki keprihatinan serius tentang potensi bahaya bagi ibu dan bayi dengan selain aman, persalinan juga harus memberikan kenyamanan dan menghormati ibu. Ini dikenal sebagai *asuhan persalinan yang berpusat pada ibu* antara lain :

a. Dukungan Emosional

- 1) Kehadiran suami/keluarga
- 2) Komunikasi yang baik dari tenaga kesehatan
- 3) Memberikan rasa aman dan percaya diri

b. Pengurangan Nyeri Secara Non-Farmakologis

- 1) Teknik pernapasan dan relaksasi
- 2) Pijat (massage)
- 3) Kompres hangat
- 4) Musik atau distraksi

c. Kebebasan Posisi dan Mobilisasi

Ibu diperbolehkan bergerak dan memilih posisi yang nyaman:

- 1) Berdiri
- 2) Jongkok
- 3) Miring
- 4) Duduk

d. Lingkungan yang Mendukung

- 1) Ruangan bersih, tenang, dan privasi terjaga
- 2) Pencahayaan yang nyaman
- 3) Minim intervensi yang tidak perlu

4. Integrasi Aman dan Nyaman dalam Persalinan

Persalinan yang ideal adalah yang menggabungkan aspek keselamatan medis dan kenyamanan psikologis, yaitu:

- a. Intervensi dilakukan hanya jika diperlukan
- b. Ibu dilibatkan dalam pengambilan keputusan
- c. Mengutamakan proses alami
- d. Tetap siap menghadapi kondisi darurat

Pendekatan ini terbukti:

- a. Mengurangi trauma persalinan
- b. Mempercepat pemulihan ibu
- c. Meningkatkan keberhasilan menyusui
- d. Memperkuat ikatan ibu dan bayi

G. Simpulan

Persalinan yang aman dan nyaman merupakan kombinasi antara pelayanan kesehatan yang berkualitas dan dukungan emosional kepada ibu. Persalinan yang aman fokus pada keselamatan ibu dan bayi, sedangkan persalinan nyaman membantu ibu merasa tenang dan percaya diri selama proses melahirkan.

Persalinan yang aman dan nyaman berpusat pada perempuan merupakan pendekatan pelayanan maternitas yang menempatkan perempuan sebagai pusat perhatian. Pelayanan ini tidak hanya berfokus pada keselamatan ibu dan bayi, tetapi juga memperhatikan kenyamanan, hak, martabat, serta kebutuhan emosional perempuan selama persalinan. Dengan dukungan tenaga kesehatan yang profesional, lingkungan yang nyaman, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, proses persalinan dapat menjadi pengalaman yang positif, aman, dan bermakna bagi ibu maupun keluarga.

Dengan persiapan yang baik, dukungan keluarga, serta bantuan tenaga kesehatan, persalinan dapat berlangsung secara lancar dan sehat. Konsep dasar persalinan normal tidak hanya berfokus pada proses biologis, tetapi juga melibatkan aspek psikologis dan sosial. Persalinan yang aman dan nyaman adalah kombinasi antara pelayanan medis yang tepat dan dukungan emosional yang optimal. Dengan pendekatan ini, diharapkan pengalaman persalinan menjadi lebih positif dan risiko komplikasi dapat ditekan seminimal mungkin.

H. Referensi

- Bohren, M. A., Mehrtash, H., Fawole, B., et al. (2019). *How women are treated during facility-based childbirth in four countries: A cross-sectional study with labour observations and community-based surveys*. The Lancet, 394(10210), 1750–1763.
- Bohren, M. A., Vogel, J. P., Hunter, E. C., et al. (2015). *The mistreatment of women during childbirth in health facilities globally: A mixed-methods systematic review*. PLoS Medicine, 12(6), e1001847.
- Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal Saifuddin AB, dkk. *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Cantor, A. G., Jungbauer, R. M., Skelly, A. C., et al. (2024). *Respectful Maternity Care: A Systematic Review*. Annals of Internal Medicine, 177(1), 50–64.
- Habib, H. H., Mwaisaka, J., Torpey, K., et al. (2023). *Are respectful maternity care interventions effective in reducing intrapartum mistreatment against adolescents? A systematic review*. Frontiers in Global Women's Health, 4, 1048441.
- Haghdoost, S., Iravani, M., Rahmani, A. H., & Montazeri, S. (2024). *Midwives' experience of respectful maternity care globally: A meta-synthesis*. Nursing Ethics, 31(5)
- Harvey, Sheila et., al. *Evaluation of satisfaction with midwifery care*. *Midwifery* [Volume 18, Issue 4](https://doi.org/10.1054/midw.2002.0317), December 2002, Pages 260-267 <https://doi.org/10.1054/midw.2002.0317>
- Humenick, Sharron S. *The Life-Changing Significance of Normal Birth*. *Journal of Perinatal Education*, 15(4), 1–3, doi: 10.1624/105812406X151330
- Ilmu Kebidanan Prawirohardjo S. *Ilmu Kebidanan*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Kemenkes RI. 2020. Kurikulum Pelatihan Penanganan *Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal Bagi Dokter Umum, Bidan dan Perawat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer*. Jakarta : Kemenkes RI
- Kemenkes RI. 2022. Profil kesehatan Indonesia 2021. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal, Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Manuaba, I. B. G. (2014). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB*. Jakarta: EGC.
- Midwifery and Women's Health Pairman S, Tracy S, Dahlen H, Dixon L. *Midwifery: Preparation for Practice*. Australia: Elsevier.

- Saifuddin, A. B. (2014). *Buku Acuan Nasional Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka.
- Vogel, J. P., Bohren, M. A., Tunçalp, Ö., et al. (2020). *Transforming intrapartum care: Respectful maternity care*. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 67, 113–126.
- World Health Organization (WHO). (2018). *WHO Recommendations: Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2025). *Compendium on respectful maternal and newborn care*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. *WHO Labour Care Guide User's Manual*. Who. 2020. 1–34p.

I. Glosarium

AKI	= Angka Kematian Ibu
CTG	= Cardiotokografi
HPP	= Haemorrhagie Postpartum
WHO	= World Health Organisation
IM	= Intra Muscular

CHAPTER 2

PENGKAJIAN KEBIDANAN SELAMA PROSES PERSALINAN

Ernita Prima Noviyani, S.ST., Bdn., M.Kes.

A. Pendahuluan

Persalinan merupakan proses fisiologis yang kompleks dan dinamis, melibatkan interaksi antara faktor ibu, janin, dan lingkungan. Keberhasilan asuhan persalinan sangat ditentukan oleh ketepatan pengkajian kebidanan yang dilakukan secara komprehensif, sistematis, dan berkesinambungan.

Pengkajian kebidanan selama proses persalinan bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi kondisi ibu dan janin secara dini
2. Menentukan kemajuan persalinan
3. Mendeteksi komplikasi secara cepat
4. Menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis

Pemahaman tentang pengkajian penilaian klinis yang tepat terhadap kemajuan persalinan sangat penting untuk memastikan hasil terbaik bagi ibu dan bayi baru lahir. Penting untuk memiliki dasar yang baik mengenai apa yang dianggap sebagai kemajuan persalinan normal dengan mengidentifikasi berbagai tahapan dan fase secara benar, serta memahami faktor-faktor yang menyebabkan kemajuan persalinan (Swier, 2021). Bidan sebagai tenaga kesehatan lini terdepan memiliki peran penting dalam melakukan pengkajian yang akurat untuk menjamin keselamatan ibu dan bayi.

B. Konsep Dasar Pengkajian Persalinan

Pengkajian kebidanan adalah proses pengumpulan data yang sistematis dan berkesinambungan untuk menilai status kesehatan ibu dan janin selama persalinan.

Pengkajian dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Holistik (bio-psiko-sosial-spiritual)

Asuhan memandang ibu bersalin secara menyeluruh. Tidak hanya memantau kondisi fisik (bio) dan psikologis/mental (psiko), tetapi juga dukungan dari keluarga (sosial) serta keyakinan atau nilai-nilai spiritual yang dianut ibu selama proses melahirkan. Pendekatan holistik diperlukan karena seluruh aspek tersebut saling berkaitan dan memengaruhi kesiapan ibu dalam

menghadapi persalinan serta peran barunya sebagai orang tua. Asuhan yang menyeluruh akan membantu perawat dalam menyusun rencana tindakan yang tepat, melaksanakan intervensi secara efektif, dan melakukan evaluasi terhadap respons ibu hamil secara optimal (Ns Nurul Atikah et al., 2026).

2. Kontinu (berulang sesuai fase persalinan)

Pengkajian bersifat dinamis dan terus-menerus. Bidan atau tenaga medis akan terus melakukan penilaian ulang pada setiap fase persalinan untuk melihat respons tubuh ibu terhadap kemajuan persalinan dan mendeteksi adanya komplikasi.

3. Objektif dan subjektif

Pengumpulan data dilakukan dari dua arah. **Data subjektif** didapatkan dari keluhan dan perasaan yang dirasakan langsung oleh ibu (misalnya: skala nyeri atau kecemasan). **Data objektif** didapatkan dari hasil pemeriksaan fisik, observasi, dan pemeriksaan penunjang (misalnya: hasil CTG, tekanan darah, atau pembukaan serviks).

4. Berbasis bukti (*evidence-based practice*)

Semua tindakan, observasi, dan intervensi yang direncanakan harus didasarkan pada penelitian klinis terbaru yang telah teruji dan terbukti aman serta efektif, bukan sekadar kebiasaan turun-temurun.

C. Komponen Pengkajian Kebidanan Selama Persalinan

1. Pengkajian Data Subjektif (Anamnesis)

Data subjektif adalah informasi yang diceritakan ibu tentang apa yang dirasakannya, apa yang sedang dan telah dialaminya. Data subjektif juga meliputi informasi tambahan yang diceritakan oleh para anggota keluarga tentang status ibu, terutama jika hal tersebut dapat ditelusuri untuk mengetahui penyebab masalah atau kondisi gawat-darurat seperti rasa nyeri, kehilangan, kesadaran atau syok.

a. Identitas

- Nama, umur, pendidikan, pekerjaan
- Gravida, paritas, abortus (GPA)
- Hari pertama haid terakhir
- Kapan bayi akan lahir (menurut taksiran ibu)
- Riwayat alergi obat-obatan tertentu

b. Keluhan utama

Menanyakan riwayat kehamilan sekarang:

- *Apakah ibu pernah melakukan pemeriksaan antenatal? Jika ya, periksa kartu asuhan antenatalnya (jika mungkin)*

- Kontraksi (frekuensi, durasi, intensitas). *(Kapan mulai terjadi kontraksi? Apakah kontraksi teratur? Seberapa sering kontraksi terjadi?)*

c. Pergerakan Janin

- *Apakah ibu masih merasakan gerakan janin? (Menanyakan frekuensi dan kepastian gerakan janin dalam 24 jam terakhir).*

d. Tanda-Tanda Peralinan

- *Apakah ada nyeri pinggang atau perut ?*
- *Apakah ada pengeluaran lendir bercampur darah (bloody show) ?*
- *Apakah selaput ketuban sudah pecah? Jika ya, apa warna cairan ketuban? Apakah kental atau encer? Kapan saat selaput ketuban pecah? (Periksa perineum ibu) untuk melihat air ketuban di sana atau membasahi pakaiannya)*
- *Apakah cairan ketuban yang keluar bercampur darah? Apakah hanya berupa bercak atau darah segar per vaginam? (Periksa perineum ibu untuk melihat darah segar atau lender bercampur darah disana atau periksa di pakaian ibu).*

e. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

- *Kapan ibu terakhir kali makan dan minum?*
- *Apakah ibu mengalami kesulitan untuk berkemih?*

f. Riwayat Kehamilan dan Persalinan sebelumnya :

- *Apakah ada masalah selama persalinan atau kelahiran bayi sebelumnya (bedah sesar, persalinan dengan ekstraksi vakum atau forceps, induksi atau augmentasi, hipertensi yang diinduksi oleh kehamilan, preeklamsia/eklamsia, perdarahan pascapersalinan)?*
- *Berapa berat badan bayi yang paling besar pernah ibu lahirkan?*
- *Apakah ibu mempunyai bayi bermasalah pada kehamilan/persalinan sebelumnya?*
- *Komplikasi terdahulu (preeklamsia, perdarahan, dll.)*
- *Penyakit penyerta atau Riwayat medis lainnya (masalah pernapasan, hipertensi, gangguan jantung, berkemih, dll)*
- *Masalah medis saat ini (sakit kepala, gangguan penglihatan, pusing, atau nyeri epigastrium). Jika ada, periksa tekanan darah dan proteinuria.*
- *Pertanyaan tentang hal-hal yang belum jelas atau berbagi bentuk kekhawatiran lainnya.*

g. Aspek psikologis

Persalinan adalah pengalaman psikologis, fisiologis, dan emosional yang mendalam. Kondisi mental ibu yang sering disebut sebagai "psikis" selama persalinan, merupakan faktor inti dalam proses persalinan dan sangat

memengaruhi kesehatan mental selama persalinan maupun pascapersalinan (Olza et al., 2018).

1) Kecemasan

2) Dukungan keluarga

Dukungan dan anjurkan suami dan anggota keluarga untuk mendampingi ibu selama persalinan dan proses kelahiran bayinya. Anjurkan mereka untuk berperan aktif dalam mendukung dan mengenali berbagai upaya yang mungkin sangat membantu kenyamanan ibu. Hargai keinginan ibu untuk menghadirkan teman atau saudara yang secara khusus diminta untuk menemaninya (Enkin et al., 2001)

3) Persepsi terhadap persalinan

Perjalanan psikologis persalinan dibentuk oleh harapan seorang wanita, rasa kendali yang dimilikinya, dan seberapa besar dukungan yang ia rasakan dari tim perawatannya (Hoffmann & Banse, 2021).

- *Pola Pikir Terkait Persalinan*: Bagaimana seorang ibu memandang persalinan (misalnya, sebagai peristiwa fisiologis alami versus prosedur yang sangat medis) sangat memengaruhi keputusan persalinannya dan bagaimana ia memproses rasa sakit dan hasil persalinan.
- *Nyeri dan Penanganannya*: Antisipasi dan pengelolaan nyeri persalinan sangat berkaitan dengan psikologi. Lingkungan yang mendukung dan persalinan yang terkelola dengan baik dapat menghasilkan perasaan berdaya, sedangkan nyeri yang tidak terkelola dengan baik atau perasaan tidak berdaya dapat meningkatkan risiko pengalaman persalinan yang negatif.
- *Lingkungan Neurohormonal*: Otak ibu dibanjiri neurohormon spesifik (seperti oksitosin dan endorfin) selama persalinan fisiologis, yang mendorong ikatan tetapi juga membuat pengalaman tersebut sangat emosional dan "terpatri" dalam ingatan (Olza et al., 2020).

2. Pengkajian Data Objektif (Pemeriksaan Fisik)

Data objektif adalah informasi yang dikumpulkan berdasarkan pemeriksaan /pengamatan terhadap ibu dan bayi serta tingkat kenyamanan fisik ibu bersalin. Hasil pemeriksaan fisik dan anamnesis diolah untuk membuat keputusan klinik, menegakkan diagnosis dan mengembangkan rencana asuhan atau keperawatan yang paling sesuai dengan kondisi ibu. Jelaskan pada ibu dan keluarganya tentang apa yang dilakukan, diperiksa dan tujuannya. Anjurkan mereka untuk bertanya dan jawab pertanyaan yang dianjurkan agar mereka memahami kepentingan untuk melakukan pemeriksaan (JNPK-KR, 2017).

a. Pemeriksaan umum

- 1) Keadaan umum ibu
- 2) Kesadaran
- 3) Tanda vital:
 - Tekanan darah
 - Nadi
 - Suhu
 - Respirasi

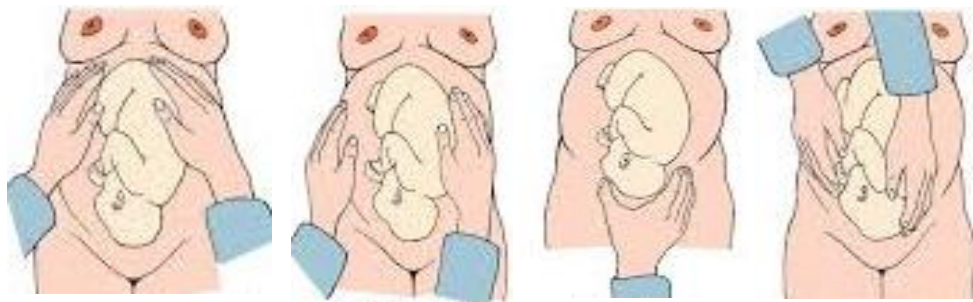
b. Pemeriksaan obstetri

1) Inspeksi

- Bentuk abdomen
- Gerakan janin

2) Palpasi (Leopold)

a) Menentukan Tinggi Fundus Uteri



Leopold 1:

Menentukan tinggi fundus dan bagian tubuh bayi di fundus

Leopold 2:

Menentukan bagian tubuh bayi yang berada di lateral kanan dan kiri korpus uteri

Leopold 3:

Menentukan bagian terbawah janin

Leopold 4:

Menentukan seberapa jauh bagian terbawah telah memasuki

Gambar 2.1: Perasat Leopold

Dengan perasat Leopold 1, ditentukan bagian mana dari tubuh bayi yang menempati fundus uteri (Gambar 3.1). untuk pengukuran tinggi fundus yang akan dikaitkan dengan taksiran berat bayi, sebaiknya digunakan pita pengukur dan dilakukan saat uterus tidak sedang berkontraksi. Ibu diposisi setengah duduk kemudian tempelkan ujung pita (posisi melebar) mulai dari tepi atas simpisis pubis, kemudian rentangkan pita mengikuti aksis/linea mediana dinding depan abdomen hingga ke puncak fundus (lihat Gambar 3.2). Jarak antara tepi atas simpisis pubis dan puncak fundus uteri adalah tinggi fundus uteri (JNPK-KR, 2017).



Gambar 2.2: Menentukan tinggi fundus uteri

b) Menentukan letak, posisi, dan presentasi janin

Untuk menentukan presentasi bayi dapat digunakan perasat Leopold 3 :

- Berdiri di samping dan menghadap ke arah kepala ibu (fleksikan sendi panggul dan lutut)
- Untuk menentukan apakah presentasinya adalah kepala atau bokong maka perhatikan dan pertimbangkan bentuk, ukuran dan kepadatan bagian tersebut. Bagian berbentuk bulat, teraba keras, berbatas tegas dan mudah digerakkan (belum masuk rongga panggul) biasanya adalah kepala. Jika bentuknya kurang tegas, teraba kenyal, relatif lebih besar, dan sulit terpegang secara mantap maka bagian tersebut biasanya adalah bokong. Istilah sungsang digunakan untuk menunjukkan bahwa bagian terbawah adalah kebalikan dari kepala atau diidentikkan sebagai bokong.
- Dengan ibu jari dan jari tengah dari satu tangan (hati-hati dan mantap), pegang bagian terbawah janin yang mengisi bagian bawah abdomen (di atas simpisis pubis) ibu. Bagian yang berada di antara ibu jari tengah penolong adalah penunjuk presentasi bayi.
- Jika bagian terbawah janin belum masuk ke rongga panggul maka bagian tersebut masih dapat digerakkan. Jika telah memasuki rongga panggul maka bagian terbawah janin sulit atau tidak dapat digerakkan lagi (JNPK-KR, 2017).

c) Menentukan penurunan bagian terbawah janin

Pemeriksaan penurunan bagian terbawah janin ke dalam rongga panggul melalui pengukuran pada dinding abdomen akan memberikan tingkat kenyamanan yang lebih baik bagi ibu jika dibandingkan dengan melakukan pemeriksaan dalam (*vaginal toucher*). Selain itu, cara penilaian diatas (bila dilakukan secara benar) dapat memberikan informasi yang

sama baiknya dengan hasil periksa dalam tentang kemajuan persalinan (penurunan bagian terbawah janin) dan dapat mencegah periksa dalam yang tidak perlu atau berlebihan.

Penilaian penurunan kepala janin dilakukan dengan menghitung proporsi bagian terbawah janin yang masih berada di atas tepi atas simfisis dan dapat diukur dengan lima jari tangan pemeriksa (perlimaan). Bagian di atas simfisi adalah proporsi yang belum masuk pintu atas panggul dan sisanya (tidak teraba menunjukkan sejauh mana bagian terbawah janin telah masuk ke dalam rongga panggul (lihat Gambar 3.3). Penurunan bagian terbawah dengan metode lima jari (perlimaan) adalah (JNPK-KR, 2017):

- 5/5 jika bagian terbawah janin seluruhnya teraba di atas simfisis pubis
- 4/5 jika sebagian (1/5) bagian terbawah janin telah memasuki pintu atas panggul
- 3/5 jika sebagian (2/5) bagian terbawah janin telah memasuki rongga panggul
- 2/5 jika hanya sebagian dari bagian terbawah janin masih berada diatas simfisis dan 3/5 bagian telah turun melewati bidang tengah rongga panggul (tidak dapat digerakkan)
- 1/5 jika hanya 1 dari 5 jari masih dapat meraba bagian terbawah janin yang berada diatas simfisis dan 4/5 bagian telah masuk ke dalam rongga panggul
- 0/5 jika bagian terbawah janin sudah tidak dapat diraba dari pemeriksaan luar dan seluruh bagian terbawah janin sudah masuk ke dalam rongga panggul



Gambar 2.3: Menentukan penurunan janin dengan metoda perlimaan

3) Auskultasi

- Denyut jantung janin (DJJ)

Menggunakan Doppler atau stetoskop Laennec untuk menghitung frekuensi, ritme, dan keteraturan DJJ di antara kontraksi dan segera setelah kontraksi.

- Normal DJJ: 120–160 x/menit

4) Pemeriksaan dalam (*Vaginal Toucher*/VT)

Sebelum melakukan periksa dalam, cuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir, kemudian keringkan dengan handuk kering dan bersih. Minta ibu untuk berkemih dan mencuci area genitalia (jika ibu belum melakukannya) dengan sabun dan air. Jelaskan pada ibu setiap langkah yang akan dilakukan selama pemeriksaan (JNPK-KR, 2017). Tenangkan hati dan anjurkan ibu untuk rileks. Pastikan privasi ibu terjaga selama pemeriksaan dilakukan.

a) Periksa genitalia eksterna

Perhatikan apakah ada luka atau masa (benjolan) termasuk kondiloma, varises vulva dan rektum, atau luka parut dan perineum.

b) Nilai cairan vagina

Tentukan apakah ada bercak darah, perdarahan pervaginam, atau mekonium:

- Jika ada perdarahan pervaginam, **jangan lakukan pemeriksaan dalam**
- Jika ketuban sudah pecah, lihat warna dan bau ketuban. Jika terlihat pewarna mekonium, nilai apakah kental atau encer dan periksa DJJ:
- Jika mekonium encer dan DJJ normal, teruskan memantau DJJ dengan seksama menurut petunjuk pada partograf. Jika tanda-tanda akan terjadi gawat janin, lakukan rujukan segera.
- Jika mekonium kental, nilai DJJ dan rujuk segera
- Jika tercium bau busuk, mungkin telah terjadi infeksi (korioamnionitis) dan rujuk segera.

c) Nilai kondisi vagina. Luka parut di vagina mengindikasikan adanya riwayat robekan perineum atau tindakan episiotomi sebelumnya. Hal ini merupakan informasi penting untuk menentukan tindakan pada saat kelahiran bayi.

d) Pemeriksaan serviks: Diukur dari pembukaan 1 cm hingga lengkap (10 cm).

e) Penipisan serviks (*effacement*): Dinyatakan dalam persentase (0% - 100%).

f) Patikan tali pusat dan/atau bagian-bagian kecil (tangan atau kaki) tidak teraba pada saat melakukan pemeriksaan dalam. Jika teraba maka lakukan langkah kegawatdaruratan dan segera rujuk ibu ke fasilitas kesehatan yang sesuai.

g) Penurunan bagian terendah janin:

Nilai penurunan bagian terbawah janin dan tentukan apakah bagian tersebut telah masuk ke dalam rongga panggul. Menilai sejauh mana kepala janin turun menggunakan bidan Hodge (Hodge I-IV). Bandingkan tingkat penurunan kepala dari hasil pemeriksaan dalam dan pemeriksaan melalui dinding perut (perlimaan) untuk menentukan kemajuan persalinan.

h) Kondisi ketuban: Jika selaput ketuban belum pecah, jangan melakukan tindakan amniotomi (merobeknya).

Alasannya: Amniotomi sebelum waktunya dapat meningkatkan risiko infeksi terhadap ibu dan bayi, juga gawat janin akibat prolapsus funikula, infeksi intrauterin dan partus kering.

i) Presentasi dan posisi janin

Pada presentasi kepala, tentukan penunjuknya (ubun-ubun kecil, ubun-ubun besar atau fontanela magna) dan celah (sutura) sagitalis untuk menilai derajat penyusupan/tumpang tindih tulang kepala dan apakah ukuran kepala janin sesuai dengan ukuran jalan lahir.

3. Pengkajian Kemajuan Persalinan

Kemajuan persalinan dinilai menggunakan:

a. Partograf

Partograf merupakan alat penting untuk:

- Memantau pembukaan serviks
- Menilai penurunan kepala janin
- Mendeteksi persalinan lama

b. Parameter yang dipantau:

- Pembukaan serviks
- Frekuensi dan kekuatan kontraksi
- DJJ
- Tekanan darah ibu
- Produksi urin

D. Pengkajian Berdasarkan Kala Persalinan

1. Kala I (Pembukaan)

a. Fase laten dan aktif

- **Fase laten:** dimulai sejak awal kontraksi yang menyebabkan penipisan dan pembukaan serviks secara bertahap. Berlangsung hingga serviks membuka hingga kurang dari 4 cm. Pada umumnya, fase laten berlangsung antara 6 hingga 8 jam.
- **Fase aktif:** Frekuensi dan lama kontraksi uterus akan meningkat secara bertahap (kontraksi dianggap adekuat/memadai jika terjadi tiga kali atau lebih dalam waktu 10 menit, dan berlangsung selama 40 detik atau lebih). Dari pembukaan 4 cm hingga mencapai pembukaan lengkap atau 10 cm, akan terjadi dengan kecepatan rata-rata 1 cm per jam (nullipara atau primigravida) atau lebih dari 1 cm hingga 2 cm. terjadi penurunan bagian terbawah janin.

b. Fokus pengkajian:

- 1) Tinggi fundus uteri (TFU)
- 2) Kontraksi uterus

Memantau kontraksi uterus dengan menentukan frekuensi dan durasi dari setiap kontraksi yang terjadi. Pada fase aktif, minimal terjadi tiga kontraksi dalam 10 menit dan lama kontraksi adalah 40 detik atau lebih. Di antara dua kontraksi akan terjadi relaksasi dinding uterus.

- 3) Pembukaan serviks
- 4) DJJ (denyut jantung janin)

Gunakan fetoskop Pinnards atau Doppler untuk mendengar denyut jantung janin (DJJ) di dalam rahim ibu dan untuk menghitung jumlah denyut jantung janin per menit, gunakan jarum detik pada jam dinding atau jam tangan. Tentukan titik tertentu pada dinding abdomen ibu dimana suara DJJ terdengar paling kuat.

Tip: Jika DJJ sulit untuk ditemukan, lakukan palpasi abdomen ibu untuk menentukan lokasi punggung bayi. Biasanya rambatan suara DJJ lebih mudah didengar melalui dinding abdomen pada sisi yang sama dengan punggung. Bayi.

5) Kondisi psikologis ibu

Tingkat kecemasan wanita selama bersalin akan meningkat jika ia tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya atau yang disampaikan kepadanya. Wanita bersalin biasanya akan mengutarakan kekhawatirannya jika ditanyai. Dari beberapa problem psikologis pra melahirkan yang telah ditemukan dilapangan, maka akan dikorelasikan dengan yang

disampaikan oleh Yanti (2009: 38) yaitu problem pra melahirkan diantaranya:

- a. Meningkatnya kecemasan, semakin meningkatnya kecemasan maka intensitas nyeri semakin tinggi
- b. Kelelahan, kehabisan tenaga, dan kekhawatiran ibu mengakibatkan intensitas nyeri semakin kuat mengakibatkan siklus stres-nyeri-stres sehingga ibu tidak mampu bertahan lagi
- c. Stres melahirkan juga terjadi pada janin yang berakibat makin lamanya proses persalinan sehingga mengakibatkan kegawatan pada bayi
- d. Meningkatnya plasma kortisol yang berakibat menurunnya respon imun ibu dan janin sehingga stres bisa membahayakan ibu dan bayi.

Menurut hasil penelitian Dr. Roberto Sosa (2001) yang dikutip dari Musbikin tentang pendamping atau kehadiran orang kedua dalam proses persalinan, yaitu menemukan bahwa para ibu yang didampingi seorang sahabat atau keluarga dekat (khususnya suami) selama proses persalinan berlangsung, memiliki risiko lebih kecil mengalami komplikasi yang memerlukan tindakan medis daripada mereka yang tanpa pendampingan.

2. Kala II (Pengeluaran Janin)

Pengkajian pada kala dua persalinan dilakukan dari mulai adanya gejala dan tanda kala dua hingga bayi lahir. Pengkajian kala dua dilakukan agar mampu menangani berbagai proses di dalam periode tersebut dalam mencegah terjadinya berbagai penyulit, mengenali gangguan atau komplikasi kala dua sejak tahap paling dini, melakukan resusitasi dan stabilisasi kegawat-daruratan medik dan merujuk ibu bersalin secara optimal dan tepat waktu.

- a. Gejala dan tanda kala II persalinan:
 - 1) Ibu merasa ingin meneran bersamaan dengan terjadinya kontraksi
 - 2) Ibu merasa adanya peningkatan tekanan pada rektum dan/atau vaginanya
 - 3) Perineum menonjol
 - 4) Vulva dan sfingter ani membuka
 - 5) Meningkatnya pengeluaran lender bercampur darah

Pengkajian:

- a. Kemajuan penurunan kepala
- b. DJJ setiap kontraksi
- c. Kondisi ibu (kelelahan)

3. Kala III (Pengeluaran Plasenta)

- a. Tanda pelepasan plasenta:
 - 1) Perubahan bentuk uterus

- 2) Semburan darah
- 3) Tali pusat memanjang

4. Kala IV (Observasi)

- a. 2 jam pertama postpartum
- b. Fokus:
 - Perdarahan
 - Kontraksi uterus
 - Tanda vital
 - Kandung kemih

E. Identifikasi Masalah dan Diagnosis Kebidanan

Berdasarkan hasil pengkajian, bidan dapat menetapkan:

1. Diagnosis kebidanan
2. Masalah potensial
3. Kebutuhan tindakan segera

Contoh:

1. Persalinan normal kala I fase aktif
2. Persalinan dengan risiko (partus lama, gawat janin)

F. Dokumentasi Pengkajian

Dokumentasi dilakukan secara lengkap dan akurat menggunakan:

1. SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Planning)
2. Partograf
3. Rekam medis

Dokumentasi yang baik:

- Mendukung kontinuitas asuhan
- Sebagai bukti legal
- Memudahkan evaluasi

G. Peran Bidan dalam Pengkajian Persalinan

Bidan berperan sebagai:

1. *Care provider*

Peran dan tanggungjawab bidan yang pertama yaitu sebagai care provider (pemberi asuhan kebidanan) yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan untuk memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman dan holistik sesuai dengan evidence based dengan memperhatikan aspek sosial budaya terhadap ibu hamil, bersalin, nifas dan menyusui, bayi baru lahir, balita, anak prasekolah, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana pada kondisi normal berdasarkan

standar praktik kebidanan sesuai kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 dan kode etik profesi bidan sesuai dengan Keputusan Menteri kesehatan nomor HK.01.07/ MENKES/320/2020 (Nurjasmi et al., 2020)

2. *Decision maker*

Seseorang yang mempunyai kemampuan mengambil keputusan klinik dalam asuhan kebidanan kepada individu, keluarga dan masyarakat dengan menggunakan prinsip partnership (kerjasama).

3. *Educator*

Dalam perannya sebagai educator (Belon dan Croizer, 2005), bidan memiliki tanggung jawab penting untuk menyediakan informasi Kesehatan yang akurat dan mudah dipahami oleh pasien. Edukasi ini mencakup berbagai aspek Kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan, dan masa nifas, serta perawatan bayi. Bidan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik setiap pasien, mengingat bahwa setiap individu memiliki latar belakang, tingkat pengetahuan, dan kebutuhan informasi yang berbeda (Amalia et al., 2024)

4. *Advocator*

Peran bidan sebagai advocator yaitu bidan berkomitmen untuk mempromosikan dan melindungi hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual. Mereka menggunakan suara mereka untuk berbicara atas nama pasien, terutama dalam situasi di mana pasien mungkin tidak dapat berbicara untuk diri mereka sendiri. Ini termasuk advokasi untuk akses yang lebih baik ke pelayanan kebidanan, kondisi persalinan yang aman, dan hak untuk membuat keputusan informasi mengenai perawatan kesehatan mereka (Amalia et al., 2024).

Pendekatan yang digunakan dalam melakukan pengkajian pada ibu dan bayi:

a. *Woman-centered care*

Women Centered Care adalah asuhan yang berorientasi pada wanita. Perawatan yang berpusat pada wanita difokuskan pada kebutuhan individu wanita itu sendiri, bukan pada kebutuhan bidan ataupun institusi terkait. Dalam Hal ini Bidan difokuskan memberikan dukungan pada wanita dalam upaya memperoleh status yang sama di masyarakat untuk memilih dan memutuskan perawatan kesehatan dirinya. *Women Centered Care* harus melibatkan hubungan baik antara wanita dan bidan dalam pemberian perawatan. Hubungan tersebut berfungsi sebagai peluang untuk membangun hubungan jangka panjang antara perempuan dan penyedia layanan kesehatan; memungkinkan pemberian perawatan sesuai kebutuhan;

menghormati hak perempuan untuk mengambil keputusan terkait perawatan mereka dan mendukung otonomi mereka dalam membuat pilihan atau keputusan yang mereka anggap terbaik; memahami dan menghormati latar belakang budaya, nilai-nilai pribadi, dan keyakinan perempuan, serta menyediakan perawatan yang sensitif dan responsif terhadap aspek-aspek tersebut; menawarkan peluang untuk menetapkan batasan bagi wanita dan bidan serta untuk mengenali kendala yang dapat memengaruhi tanggung jawab mereka (Gregory et al., 2025).

b. *Respectful maternity care*

Respectful maternity care (RMC) mengacu pada perlakuan manusiawi dan bermartabat terhadap wanita yang melahirkan selama kehamilan, persalinan, dan periode setelah melahirkan. Ini menghormati hak dan pilihannya melalui komunikasi, tindakan, dan sikap yang mendukung. Karena perilaku dan lingkungan yang tidak menghormati dan kasar menurunkan kualitas perawatan maternitas, mengidentifikasi dan mengatasi perlakuan buruk merupakan komponen penting dalam menumbuhkan RMC di fasilitas kesehatan. Perawatan persalinan yang penuh hormat adalah hak perempuan, bukan kemewahan. Memastikan bahwa perempuan tidak hanya puas dengan perawatan mereka, tetapi juga memiliki pengalaman persalinan yang positif dapat menjadi katalis untuk memastikan mereka bertahan hidup dan berkembang (Nassali et al., 2025).

c. *Evidence-based practice*

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), penerapan perawatan berbasis bukti sangat penting untuk meningkatkan perawatan kesehatan dan hasil kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efek dari rencana manajemen persalinan dan kelahiran normal berbasis bukti terhadap kepuasan dan pengalaman melahirkan pada wanita (Ebrahimian et al., 2025). Perawatan berbasis bukti (*evidence-based practice*) mengintegrasikan bukti ilmiah terkini dengan pengalaman klinis dan preferensi pasien untuk meningkatkan kualitas perawatan (Halawa et al., 2020). Beberapa praktik perawatan berbasis bukti yang mendorong persalinan fisiologis meliputi: inisiasi persalinan spontan, menghindari intervensi yang tidak perlu, memungkinkan mobilitas ibu selama tahapan persalinan, memberikan dukungan fisik dan psikologis selama persalinan, mengejan spontan dalam posisi tegak, dan inisiasi menyusui dini (Abalos et al., 2023).

H. Kesimpulan

Pengkajian kebidanan selama proses persalinan merupakan langkah krusial dalam menentukan keberhasilan asuhan. Pengkajian yang dilakukan secara sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan memungkinkan deteksi dini komplikasi serta pengambilan keputusan yang tepat. Dengan pengkajian yang optimal, diharapkan angka morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi dapat ditekan.

I. Referensi

- Abalos, E., Adanu, R., Bernitz, S., Binfa, L., Dao, B., Downe, S., Hofmeyr, J. G., Homer, C. S. E., Hundley, V., GaladanciGogoi, H. A., Lavender, T., Lissauer, D., Lumbiganon, P., Pattinson, R., Qureshi, Z., Stringer, J. S. A., Pujar, Y. V., Vogel, J. P., Yunis, K., ... Souza, J. P. (2023). Global research priorities related to the World Health Organization Labour Care Guide: results of a global consultation. *Reproductive Health*, 20(1). <https://doi.org/10.1186/s12978-023-01600-4>
- Amalia, R., Kirana, W., Anur, H., Olvaningsih, R., Masdah, S., Pelanjani, N. J., Siti, S., Urhuhe, A., Siburian, D., Ramadhan, K., & Wasiah, A. (2024). *Promosi Kesehatan dalam Kebidanan* (M. Sari, Ed.). Get Press Indonesia. <https://repository.poltekkes-medan.ac.id/id/eprint/746/1/PROMOSI%20KESEHATAN%20DALAM%20KEBIDANAN.pdf>
- Ebrahimian, A., Abedi, P., Cheraghian, B., & Iravani, M. (2025). The Effects of Evidence-based Management of Labor and Normal Delivery on the Satisfaction and Childbirth Experience among Primiparous Women: A Randomized Clinical Trial. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 30(6), 878–884. https://doi.org/10.4103/ijnmr.ijnmr_297_24
- Enkin, M., Keirse, M. J., Neilson, J., Crowther, C., Duley, L., Hodnett, E., & Hofmeyr, G. J. (2001). Effective care in pregnancy and childbirth: a synopsis. *Birth (Berkeley, Calif.)*, 28(1), 41–51. <https://doi.org/10.1046/j.1523-536x.2001.00041.x>
- Gregory, S., Caffrey, L., Daly, D., & Sheaf, G. (2025). How Woman-Centred Care Is Experienced and Understood in Maternity Services by Women and Professionals: A Rapid Review. *Scandinavian Journal of Caring Sciences*, 39(3). <https://doi.org/10.1111/scs.70086>
- Halawa, F., Madathil, S. C., Gittler, A., & Khasawneh, M. T. (2020). Advancing evidence-based healthcare facility design: a systematic literature review. *Health Care Management Science*, 23(3), 453–480. <https://doi.org/10.1007/s10729-020-09506-4>

- Hoffmann, L., & Banse, R. (2021). Psychological aspects of childbirth: Evidence for a birth-related mindset. *European Journal of Social Psychology*, 51(1), 124–151. <https://doi.org/10.1002/ejsp.2719>
- JNPK-KR. (2017). *Asuhan Persalinan Normal Asuhan Esensial Bagi Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir Serta Penatalaksanaan Komplikasi Segera Pascapersalinan dan Nifas* (G. Adriaansz, Ed.; 2017th ed., Vol. 8). Jaringan Nasional Pelatihan Klinik - Kesehatan Reproduksi. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia.
- Nassali, M. N., Russell, J. C., Tsuaneng, M., Tumagole, A., Mussa, A., Moreri-Ntshabele, B., Morroni, C., Moloi, T., Memo, N. B., Hanson, S., Rubgega, F. D., Sedabadi, L., Jamieson, M., Matshitsa, L., Ganagagabo, K., Shapiro, R., Lockett, R., & Hofmeyr, G. J. (2025). Promoting respectful maternity care with the WHO labor care guide and the checklist mnemonic "COPE": A quality improvement project. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 171(2), 798–804. <https://doi.org/10.1002/ijgo.70238>
- Ns Nurul Atikah, Mk., Kep Hilma Yasni, M., Juita Sari, Mk., & Afrianty, I. (2026). *Keperawatan Maternitas* (I. Afrianty, Ed.; 1st ed.). Perkumpulan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Progres Ilmiah Kesehatan. <https://promise.nchat.id>
- Nurjismi, E., Jubaedah, A., Sunarsih, N. E., Irawan, Y. L., & Herdiawati, H. (2020). *Buku Digital Standar Profesi Bidan*. Kementerian Kesehatan RI. <https://repositori-ditjen-nakes.kemkes.go.id/294/2/Buku%20digital%20Standar%20Profesi%20Bidan.pdf>
- Olza, I., Leahy-Warren, P., Benyamini, Y., Kazmierczak, M., Karlsdottir, S. I., Spyridou, A., Crespo-Mirasol, E., Takács, L., Hall, P. J., Murphy, M., Jonsdottir, S. S., Downe, S., & Nieuwenhuijze, M. J. (2018). Women's psychological experiences of physiological childbirth: A meta-synthesis. *BMJ Open*, 8(10). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-020347>
- Olza, I., Uvnas-Moberg, K., Ekström-Bergström, A., Leahy-Warren, P., Karlsdottir, S. I., Nieuwenhuijze, M., Villarmea, S., Hadjigeorgiou, E., Kazmierczak, M., Spyridou, A., & Buckley, S. (2020). Birth as a neuro-psycho-social event: An integrative model of maternal experiences and their relation to neurohormonal events during childbirth. *PLoS ONE*, 15(7 July). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0230992>
- Swier, M. M. (2021). Clinical Assessment of Labor Progress. In E. Chandrachan (Ed.), *The Global Library of Women's Medicine* (Vol. 11). Sapiens Publishing, LTD. <https://doi.org/10.3843/glowm.413923>

J. Glosarium

CTG	= <i>Cardiotocography</i> atau Kardiotokografi
DJJ	= Denyut Jantung Janin
EBP	= <i>Evidence Based Practice</i>
GPA	= Gravida, Paritas, Abortus
RMC	= <i>Respectful maternity care</i>
SOAP	= <i>Subjective, Objective, Assessment, Planning</i>
TFU	= Tinggi fundus uteri
VT	= <i>Vaginal Toucher</i> /Pemeriksaan Dalam
WCC	= <i>Women Centered Care</i>
WHO	= <i>World Health Organization</i> / Organisasi Kesehatan Dunia

CHAPTER 3

PEMANTAUAN KEMAJUAN PERSALINAN DAN KESEJAHTERAAN IBU JANIN

Sulastri Handayani, S.Tr.Keb., Bdn., M.Keb.

A. Pendahuluan

Persalinan adalah proses kelahiran bayi yang melibatkan serangkaian perubahan fisiologis pada ibu dan bayi, mulai dari awal kontraksi hingga bayi lahir ke dunia luar. Proses ini mencakup pembukaan serviks, turunnya bayi melalui jalan lahir, dan kelahiran bayi serta plasenta. Persalinan merupakan tahap akhir kehamilan dan memerlukan pemantauan yang cermat untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi. Dalam konteks penggunaan partograph pada persalinan, partograph adalah alat penting yang digunakan untuk memantau kemajuan persalinan dan kondisi ibu serta janin secara sistematis untuk mendeteksi adanya komplikasi sedini mungkin sehingga intervensi medis dapat dilakukan tepat waktu (Djimeli et al., 2025).

Pemantauan selama proses persalinan sangat penting karena dapat membantu mendeteksi dini adanya komplikasi pada ibu maupun janin sehingga tindakan cepat dan tepat dapat dilakukan untuk mencegah kematian atau cedera. Penggunaan alat seperti partograph memungkinkan pencatatan dan pemantauan parameter utama persalinan, termasuk kemajuan pembukaan serviks, denyut jantung janin, dan kondisi ibu, secara sistematis dan berkelanjutan. Menurut WHO, penggunaan rutin partograph dalam persalinan dapat mengurangi risiko seperti persalinan lama (prolonged labor), kebutuhan intervensi seperti peningkatan kontraksi uterus, operasi sesar darurat, dan kematian bayi (stillbirths). Oleh karena itu, pemantauan yang efektif selama persalinan sangat vital untuk mengidentifikasi kondisi abnormal yang memerlukan intervensi, seperti rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih baik, penggunaan obat penguat kontraksi, atau tindakan operasi sesar, demi keselamatan ibu dan bayi (Djimeli et al., 2025).

Secara lebih rinci, pemantauan yang baik mencegah komplikasi serius seperti persalinan terhambat, perdarahan pasca persalinan, ruptur uterus, infeksi, dan fistula obstetrik yang dapat berakibat fatal bagi ibu dan bayi. Selain itu, pemantauan yang tepat juga membantu menghindari intervensi yang tidak perlu seperti operasi caesar. Dengan demikian, pemantauan selama persalinan adalah bagian integral dari pelayanan kesehatan maternal yang berkualitas dan dapat

menurunkan angka kematian ibu dan bayi secara signifikan (Godfrey et al., 2025). Keselamatan ibu dan janin sangat erat dan saling mempengaruhi selama proses persalinan. Keamanan dan kesejahteraan ibu secara langsung berdampak pada kesehatan janin, dan sebaliknya. Jika proses persalinan dikendalikan dengan baik melalui pemantauan yang tepat, penanganan komplikasi secara cepat dan terampil, serta dukungan yang memadai seperti companionship dan posisi yang optimal, maka risiko komplikasi bagi ibu dan janin dapat diminimalkan. Sebaliknya, ketidakmampuan mendeteksi atau mengelola masalah seperti obstructed labour, distosia bahu, atau malposisi kepala dapat meningkatkan risiko cedera pada ibu dan kondisi janin yang memburuk, termasuk asfiksia neonatal dan kematian perinatal. Oleh karena itu, strategi yang mengutamakan keselamatan ibu juga menjamin keselamatan janin, dan keduanya harus menjadi prioritas utama dalam perawatan labor di semua tingkat fasilitas kesehatan (Hofmeyr et al., 2024).

Dalam tahap ini pentingnya *women-centered care* dalam konteks persalinan menekankan pentingnya menghormati, menghargai, dan melibatkan ibu selama proses kehamilan, persalinan, dan pembangunan badan, dengan fokus utama pada pengalaman dan kebutuhan ibu. Pendekatan ini mendorong pemberian layanan yang menghormati hak-hak ibu, mendukung pilihan dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, serta memastikan kenyamanan dan dukungan emosional selama proses persalinan. Penerapan *women centered care* tercermin dalam penekanan pada pencatatan dan dukungan yang hormat terhadap ibu, termasuk pendampingan, dan pentingnya komunikasi yang terbuka serta pengambilan keputusan bersama antara tenaga kesehatan dan ibu. Selain itu, penekanan terhadap pemberian pelayanan yang penuh penghormatan dan penyesuaian sesuai kebutuhan dan preferensi ibu menunjukkan komitmen terhadap pendekatan *women centered care* (Ubom et al., 2025).

B. Konsep Dasar Pemantauan Persalinan

Pemantauan persalinan merupakan proses terus-menerus untuk mengamati kemajuan persalinan dan kondisi kesehatan ibu serta janin selama proses persalinan berlangsung. Tujuan utamanya adalah mendeteksi secara dini tanda-tanda kemajuan persalinan yang normal maupun adanya komplikasi yang memerlukan penanganan segera. Pemantauan ini meliputi beberapa aspek utama, di antaranya (Sulistiawati et al., 2024; Wibowo & Kusumawati, 2023):

1. Tanda-tanda persalinan yang normal

- a. Kontraksi uterus teratur dan cukup kuat
- b. Pembukaan serviks yang menunjukkan kemajuan proses melahirkan
- c. Perubahan posisi dan pergerakan janin yang normal

- d. Pengeluaran cairan dari jalan lahir yang sesuai dengan kondisi persalinan

2. Indikator kemajuan persalinan

- a. Frekuensi, durasi, dan kekuatan kontraksi
- b. Perubahan pembukaan serviks dan posisi janin
- c. Jumlah dan warna cairan ketuban
- d. Pemeriksaan vital ibu seperti tekanan darah, denyut jantung, dan suhu tubuh

3. Tanda bahaya dan komplikasi

- a. Kontraksi tidak teratur atau lemah
- b. Ketuban pecah lebih awal dari waktunya tanpa kemajuan
- c. Perdarahan aktif atau adanya cairan abnormal
- d. Tanda distress janin seperti detak jantung yang tidak normal
- e. Keadaan ibu yang menunjukkan kelelahan, pusing, atau gejala lain yang mengindikasikan komplikasi

4. Peran pendidikan dan self- monitoring

- a. Memberikan pengetahuan kepada ibu mengenai tanda-tanda persalinan dan tanda bahaya
- b. Melatih ibu untuk melakukan pemantauan mandiri terhadap kontraksi, posisi, dan jumlah cairan yang keluar
- c. Membantu ibu memahami kapan saat yang tepat untuk segera ke fasilitas kesehatan

5. Prinsip utama pemantauan persalinan

- a. Risk assessment berkelanjutan
 - 1) Melakukan penilaian risiko secara sistematis setiap jam selama persalinan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya komplikasi atau tanda-tanda distress fetal.
 - 2) Penilaian ini meliputi pemeriksaan klinis serta hasil monitoring, dan dilakukan secara berkelanjutan agar tindakan medis yang diperlukan dapat segera diambil.
- b. Partisipasi dan informasi kepada ibu
 - 1) Memberikan penjelasan lengkap kepada ibu tentang pilihan metode pemantauan yang tersedia, serta risiko dan manfaatnya.
 - 2) Melibatkan ibu dalam pengambilan keputusan, termasuk mendukung pilihan sesuai keinginannya. Sehingga tercipta suasana percaya dan nyaman selama proses persalinan.
- c. Metode pemantauan yang sesuai
 - 1) Intermittent Auskultasi: pemeriksaan denyut jantung janin secara periodik dengan alat seperti doppler atau fetoscope. Biasanya digunakan pada kehamilan risiko rendah.

- 2) Cardiotocografi (CTG): pemantauan denyut jantung janin dan kontraksi uterus secara kontinue menggunakan alat khusus. Direkomendasikan terutama apabila ada faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan komplikasi.
- d. Penggunaan dan interpretasi data monitoring
 - 1) Hasil dari monitoring harus dikaji bersamaan dengan kondisi klinis ibu dan bayi secara keseluruhan.
 - 2) Perubahan pola denyut jantung yang tidak normal atau tanda-tanda lain harus direspon segera dengan langkah-langkah penanganan yang sesuai, seperti pemeriksaan lebih lanjut atau tindakan medis.
- e. Tindakan berdasarkan temuan

Jika ditemukan tanda-tanda distress fetal, seperti adanya decelerasi denyut jantung atau penurunan variabilitas, maka harus dilakukan tindakan cepat, termasuk transfer ke fasilitas yang lebih lengkap dan penanganan medis yang tepat (Fetal Monitoring in Labour NICE Guideline, 2022)

C. Parameter Pemantauan Ibu dan Janin

1. Pemeriksaan pemantauan janin (fetal monitoring)

Pemantauan janin selama persalinan dilakukan untuk memastikan bahwa bayi menerima cukup oksigen dan tidak mengalami distress. Parameter utama yang diperhatikan dalam pemantauan janin adalah (Mohan et al., 2021):

- a. Denyut jantung dasar (Baseline Heart Rate)
 - 1) Merupakan denyut jantung normal janin selama periode tenang
 - 2) Biasanya berkisar antara 110-160/mnt
 - 3) Perubahan dari rentang ini dapat menunjukkan masalah.
- b. Variabilitas
 - 1) Variasi denyut jantung yang normal menunjukkan janin dalam kondisi baik
 - 2) Variabilitas kecil atau tidak ada variabilitas bisa menjadi tanda distress atau oksigen
- c. Declaration (penurunan denyut jantung)
 - 1) Adanya penurunan denyut jantung yang sementara selama kontraksi, yang bisa normal atau menunjukkan masalah tergantung pola dan durasinya.
 - 2) Declaration yang berkepanjangan atau berat adalah tanda perlu perhatian lebih.
- d. Acceleration (peningkatan denyut jantung)

Peningkatan denyut jantung yang sementara dan biasanya menandakan janin sehat dan tidak stres
- e. Kemajuan persalinan

Penilaian kemajuan persalinan sangat membantu dalam menunjang perlangsungan persalinan, di mana hasil pemantauan merupakan dasar pertimbangan menetapkan rencana asuhan yang sesuai dengan kebutuhan ibu bersalin.

Terdapat beberapa hal yang dipantau, antara lain:

- 1) Evaluasi berkala pembukaan serviks
- 2) Posisi dan presentasi janin, memastikan kepala janin dalam posisi optimal (kepala dibawah dan menghadap posterior ibu)

2. Parameter pemantauan ibu

Selain memantau janin, kesehatan ibu juga harus diamati secara ketat, termasuk

a. Tanda vital

Tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan laju pernapasan harus dipantau secara rutin rutin untuk mendeteksi adanya komplikasi seperti preeklamsia atau infeksi

b. Faktor risiko dan kondisi medis sebelumnya

Riwayat kesehatan ibu, termasuk penyakit kronis, yang dapat memengaruhi proses persalinan dan pengawasan selama proses berlangsung

c. Tanda-tanda persalinan

Kontraksi uterus, pembukaan serviks, posisi dan keadaan jalan lahir yang harus dipantau untuk mengetahui kemajuan persalinan.

d. Pergerakan Janin (Fetal Movements)

- 1) Menggunakan metode hitung gerakan janin di rumah (contoh: metode count to ten)
- 2) Memperhatikan pola dan jumlah gerakan janin selama periode tertentu.
- 3) Melihat adanya penurunan atau perubahan pola gerakan sebagai tanda risiko.

e. Ultrasonografi (USG)

- 1) Menilai ukuran janin. Massanya, dan distribusi cairan ketuban.
- 2) Mengidentifikasi janin kecil dan memahami pola perkembangannya.

f. Biomarker

Analisis biomarker tertentu yang terkait dengan kesehatan plasenta dan janin, seperti faktor pertumbuhan dan protein lain dari plasma (Piron-Dumitrascu et al., 2025) (Singh et al., 2020)

3. Instrumen dan Metode Pemantauan

Dalam melakukan pemantauan proses persalinan, dibutuhkan berbagai metode dan alat bantu yang digunakan untuk mengukur dan memberikan hasil

pemantauan yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait asuhan yang dibutuhkan ibu bersalin.

Berikut ini terdapat beberapa instrument dan metode yang digunakan dalam memantau persalinan:

a. Metode pemantauan

1) Palpasi

Yaitu metode yang diterapkan saat dilakukan penilaian kontraksi, dan menentukan posisi janin.

2) Pemeriksaan dalam

Dilakukan untuk menilai pembukaan serviks, penurunan kepala janin, dan posisi janin.

b. Instrumen pemantauan

1) Fetoskop/Doppler

Alat ini digunakan untuk menentukan denyut jantung janin

2) Kardiotokografi(CTG)

Alat yang mencatat denyut jantung janin dan kontraksi rahim secara simultan.

3) Partograf

Yaitu alat bantu yang secara visual mencatat perkembangan persalinan secara grafis. Instrument ini berguna untuk mendeteksi awal masalah seperti partus lama dan kontraksi tidak efektif.

4) Kompetensi petugas kesehatan yang diperlukan

Seorang penolong ataupun tim penolong persalinan diharapkan memiliki kapasitas/kemampuan yang meliputi:

c. Pengetahuan tentang fisiologi persalinan. Diharapkan seorang atau tim penolong persalinan memahami tahapan-tahapan persalinan dan perubahan fisiologis yang dialami ibu dan janin selama proses persalinan.

d. Kemampuan melakukan pemeriksaan fisik yang meliputi pengukuran tanda-tanda vital dan penilaian kontraksi uterus.

e. Mampu menggunakan alat-alat pemantauan seperti doppler, CTG, dan tensimeter.

f. Mampu menafsirkan/analisis hasil pemantauan seperti DJJ, kontraksi rahim (His), serta hasil pemeriksaan dalam.

g. Memiliki kemampuan komunikasi efektif pada pasien dan keluarganya, terutama tentang kondisi selama persalinan dan memberikan edukasi yang tepat.

4. Gambaran dan interpretasi hasil pemantauan dalam persalinan

a. Pemantauan kemajuan persalinan dan kondisi ibu

Dari rangkaian pemantauan yang dilakukan selama proses persalinan pada seorang ibu bersalin (inpartu), dapat diperoleh gambaran sebagai dasar atau data untuk menegakkan diagnosis dan kondisi ibu. Kondisi ibu yang memerlukan pemantauan adalah:

1) Tanda-tanda vital

Tanda-tanda vital merupakan indikator penting yang harus dipantau selama persalinan untuk memastikan kesejahteraan ibu. Berikut adalah nilai normal dari tanda-tanda vital yang perlu dipantau pada ibu selama persalinan.

- a) Tekanan darah: Nilai normal 90/60 mmHg sampai dengan 140/90 mmHg. Tekanan darah normal menunjukkan bahwa sirkulasi baik dan jantung bekerja efisien. Jika didapatkan hasil Dimana tekanan darah tinggi ($>140/90$ mmHg) memberikan tanda potensi preeklampsia, dan kondisi ini kurang baik bagi ibu dan janin. Sedangkan tekanan darah rendah ($<90/60$ mmHg) dapat menimbulkan rasa pusing bagi ibu dan menunjukkan sirkulasi yang kurang baik.
- b) Denyut Jantung: Nilai normal 60 sampai 100 denyut per menit (dpm). Denyut jantung normal menunjukkan bahwa Tachycardia (>100 dpm) menunjukkan potensi dehidrasi, demam ataupun kecemasan. Sedangkan Bradycardia (<60 dpm) dapat menandakan kondisi jantung atau kelelahan yang berlebihan.
- c) Pernafasan: Nilai normal 12 sampai 20 kali per menit. Frekuensi pernapasan normal menggambarkan fungsi paru-paru dan oksigenasi tubuh ibu dalam kondisi baik. Takipnea (>20 kali per menit) menunjukkan kelelahan, infeksi, atau masalah pernapasan. Bradipnea (<12 kali per menit) dapat disebabkan oleh kelelahan yang sangat parah atau efek obat-obatan anestesi.
- d) Suhu tubuh: Nilai normal $36,5^{\circ}\text{C}$ sampai $37,5^{\circ}\text{C}$. Suhu $>38^{\circ}\text{C}$ mengindikasikan adanya infeksi seperti korioamnionitis, yang harus ditangani segera.

2) Kontraksi uterus

Mengobservasi frekuensi, durasi, dan intensitas kontraksi uterus bertujuan untuk menilai kemajuan persalinan. Nilai normal kontraksi uterus (his) Adalah kontraksi yang kuat setiap 2-5 menit selama fase aktif persalinan, dengan durasi 40-60 detik. His yang teratur dan kuat menunjukkan kemajuan persalinan. Kontraksi uterus terlalu sering (>5

dalam 10 menit) dapat menyebabkan stress pada janin. Sedangkan kontraksi lemah atau jarang menunjukkan perlambatan persalinan dan mungkin memerlukan intervensi.

3) Pembukaan jalan lahir

Pembukaan jalan lahir dinilai pada ostium internal. Mengukur dilatasi serviks dalam satuan sentimeter bertujuan menentukan tahapan persalinan. Pembukaan 10 cm diartikan sebagai pembukaan lengkap. Kala 1 terbagi dalam 2 fase, yaitu fase laten dan fase aktif, fase laten Adalah awal dari persalinan aktif, yang ditandai dengan kontraksi uterus yang mulai teratur, tetapi masi relative lemah dan jarang. Pada ibu primigravida, fase laten bisa berlangsung 6-20 ja. Sedangkan pada ibu multigravida rata-rata 4-14 jam. Dalam fase laten pembukaan serviks antara 0 sampai 3 cm, kontraksi mulai tertur dengan interval sekitar 5-30 menit sekali dan berlangsung sekitar 30-45 detik.

selanjutnya fase aktif adalah bagian dari kala satu persalinan di mana kontraksi menjadi lebih intens, lebih sering, dan serviks mengalami pembukaan yang lebih cepat. durasi pada ibu primigravida 3-7 jam, sedangkan pada ibu multigravida 2-6 jam pada fase aktif, dilatasi serviks 4-10 cm. kontraksi lebih kuat, lebih sering (setiap 3-5 menit), dan berlangsung 45-60 detik.

D. Pemantauan Kemajuan Persalinan dengan Partograf

Partograf adalah alat penting untuk memantau kemajuan persalinan dan mendeteksi komplikasi saat persalinan berlangsung. Meskipun WHO merekomendasikan penggunaan partograf, pemakaiannya di banyak negara berpendapatan rendah hingga menengah masih rendah karena berbagai kendala seperti kurangnya pelatihan, keterbatasan sumber daya, dan kelemahan sistemik Inovasi teknologi telah menghadirkan berbagai versi digital partograf, yang disebut partograf elektronik atau digital paperless partograph, yang sangat membantu dalam pemantauan persalinan. Partograf digital ini memberikan sejumlah kelebihan dibandingkan versi tradisional (Mugyenyi et al., 2024a):

1. Peningkatan kemudahan dan kepatuhan pengguna: Partograf elektronik lebih user friendly dan dapat dioperasikan dengan pelatihan minimal, sehingga meningkatkan tingkat pengisian dan akurasi pencatatan kemajuan persalinan.
2. Dukungan keputusan klinis
Digital partograph memberikan peringatan otomatis jika ada tanda-tanda abnormal pada kemajuan persalinan atau kondisi ibu dan janin yang memburuk, sehingga tenaga kesehatan dapat mengambil tindakan lebih cepat

3. Efisiensi waktu

Studi menunjukkan bahwa penggunaan partograf digital lebih efisien dan dapat digunakan di pusat layanan.

4. Peningkatan kualitas dokumentasi

Data yang terekam secara digital memungkinkan akses dan transfer informasi yang lebih baik antar petugas kesehatan sehingga pengambilan keputusan menjadi lebih tepat dan cepat

5. Fungsi partograf

Partograf adalah alat tradisional yang digunakan untuk memantau kemajuan persalinan dengan mencatat berbagai parameter seperti detak jantung janin, kontraksi uterus, dilatasi serviks, dan tanda-tanda maternal lainnya. Pada partograf, diagnosis prolonged (persalinan lama) didasarkan pada crossing (melewati) "action line" yang menunjukkan keterlambatan kemajuan serviks berdasarkan plot dilatasi serviks selama labor.

6. Pengisian dan kriteria kelengkapan partograf

Pengisian partograf dianggap lengkap jika memenuhi kriteria utama yaitu pencatatan detak jantung janin setiap 30 menit, frekuensi dan durasi kontraksi uterus setiap 30 menit, dan pengisian lengkap setidaknya empat bagian utama antara lain kondisi janin, kemajuan persalinan, dan kondisi ibu (Mugenyi et al., 2024b).

7. Penggunaan partograf tradisional (modifikasi WHO):

- a. Menggunakan garis alarm dan batas waktu yang tetap, yaitu dimulai dari 4 cm pembukaan serviks.
- b. Fokus pada monitoring waktu dan posisi kontraksi secara kaku dan standar tertentu.

8. Pendekatan WHO labour care guide (LCG)

- a. Mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan individual
- b. Memulai monitoring saat 5 cm pembukaan serviks dan menyesuaikan waktu serta prosesnya berdasarkan keadaan sebenarnya.
- c. Memberikan perhatian pada kondisi klinis wanita secara lebih personal dan memperhatikan tanda-tanda kemajuan alami labor.

9. Hasil implementasi

- a. Durasi fase aktif dan tahap kedua persalinan lebih singkat.
- b. Tingkat persalinan lebih tinggi, dan tingkat operasi caesar lebih rendah.
- c. Hal ini menunjukkan bahwa pemantauan yang lebih adaptif dan berbasis bukti membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat waktu dan mengurangi unnecessary intervention (Vishnu Priya et al., 2026)

E. Deteksi dini dan komplikasi

Terkait dengan deteksi dini dan komplikasi persalinan, dokumen WHO Global Maternal Sepsis Study and Awareness campaign (GLOSS) menyoroti beberapa poin penting yang relevan untuk pemahaman mengenai pengelolaan risiko maternal selama proses persalinan, terutama yang terkait dengan infeksi dan sepsis (Chimwaza et al., 2025):

1. Deteksi dini komplikasi persalinan melalui Early Warning Systems (EWS)

EWS yang dirancang khusus untuk populasi obstetrik, seperti Modified Early Obstetric Warning System (MEOWS) dan Irish Maternity Early Warning System (IMEWS), digunakan untuk mengenali tanda-tanda awal komplikasi, termasuk infeksi yang dapat mengarah pada sepsis pada wanita hamil, persalinan, dan masa postpartum. Dalam studi ini, berbagai sistem peringatan dini (21 jenis EWS) dievaluasi untuk sensitivitas dan spesifisitas dalam mengidentifikasi wanita dengan risiko komplikasi parah selama dan setelah persalinan yang berkaitan dengan sepsis. Sistem seperti NICE Risk Stratification tool dan Modified Shock Index memiliki sensitivitas tinggi dalam mendeteksi wanita dengan komplikasi infeksi, yang memungkinkannya sebagai alat yang berguna untuk deteksi dini selama periode persalinan dan postpartum.

2. Komplikasi persalinan yang berkaitan dengan infeksi dan sepsis

Infeksi selama atau setelah persalinan, seperti chorioamnionitis, infeksi luka operasi caesar, dan infeksi postpartum dapat berkembang menjadi sepsis maternal jika tidak dikenali dan ditangani secara cepat dan tepat. Komplikasi terkait termasuk disfungsi organ, kebutuhan perawatan intensif, intervensi invasif seperti drainase abses atau tindakan bedah, serta peningkatan risiko kematian ibu. Infeksi dan sepsis juga merupakan faktor pemberat dalam komplikasi persalinan lainnya, misalnya pada wanita dengan preeklamsia atau eklamsia yang kemudian mengalami infeksi nosokomial.

3. Kendala dalam deteksi dini dan penanganan komplikasi persalinan

Data medis yang tidak lengkap dan kurangnya standar dalam pencatatan vital sign dan tanda klinis lainnya selama persalinan dapat menghambat efektivitas EWS dalam mendeteksi komplikasi sejak dini. Keterbatasan validasi dan akurasi sistem peringatan dini di berbagai setting, terutama di negara dengan sumber daya rendah, menjadi tantangan dalam pengaplikasian di lapangan. Kesalahan diagnosis atau false positive yang tinggi dapat menyebabkan alarm fatigue sehingga berpotensi mengganggu pengambilan keputusan klinis.

4. Implikasi dan rekomendasi

Penggunaan EWS yang dikombinasikan dengan pemeriksaan klinis yang cermat dan pemeriksaan laboratorium dapat meningkatkan deteksi dini komplikasi persalinan akibat infeksi dan sepsis. Peningkatan pelatihan tenaga kesehatan terkait pemantauan vital sign dan tanda-tanda peringatan selama persalinan sangat penting untuk intervensi yang cepat dan tepat waktu. Perlu pengembangan lebih lanjut sistem deteksi dini yang spesifik bagi peristiwa persalinan dan penyesuaian EWS sesuai dengan setting lokal guna meningkatkan efektivitas dan utilisasi.

F. Simpulan

Pemantauan kemajuan persalinan dan kesejahteraan ibu janin merupakan bagian penting dalam pelayanan maternitas untuk memastikan proses persalinan berlangsung aman, efektif, dan sesuai dengan kondisi fisiologis ibu serta janin. Pemantauan yang dilakukan secara sistematis memungkinkan tenaga kesehatan mendeteksi secara dini adanya penyimpangan atau komplikasi, sehingga tindakan penanganan dapat diberikan secara cepat dan tepat. Penggunaan berbagai parameter pemantauan, seperti kontraksi uterus, pembukaan serviks, tanda vital ibu, serta denyut jantung janin, menjadi dasar dalam menilai kemajuan persalinan dan kondisi kesejahteraan janin selama proses berlangsung. Partograf sebagai alat pemantauan persalinan memiliki peran penting dalam membantu tenaga kesehatan mendokumentasikan perkembangan persalinan secara terstruktur dan mendeteksi risiko komplikasi, seperti persalinan lama dan distress janin. Perkembangan teknologi melalui penggunaan partograf digital dan WHO Labour Care Guide (LCG) memberikan pendekatan yang lebih adaptif, individual, dan berbasis bukti dalam pemantauan persalinan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta menurunkan intervensi yang tidak diperlukan. Selain itu, keberhasilan pemantauan persalinan sangat dipengaruhi oleh kompetensi tenaga kesehatan dalam melakukan observasi, interpretasi hasil pemantauan, komunikasi efektif, serta pengambilan keputusan klinis. Pendekatan *women-centered care* juga menjadi aspek penting dalam pelayanan persalinan karena menempatkan ibu sebagai pusat pelayanan dengan tetap menghormati hak, kebutuhan, kenyamanan, dan partisipasi aktif ibu selama proses persalinan. Dengan demikian, pemantauan persalinan yang optimal, didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten, penggunaan instrumen yang tepat, serta penerapan deteksi dini komplikasi secara berkelanjutan, dapat meningkatkan keselamatan ibu dan bayi serta berkontribusi dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian maternal maupun neonatal.

G. Referensi

- Chimwaza, Y., Hunt, A., Oliveira-Ciabati, L., Bonnett, L., Abalos, E., Cuesta, C., Souza, J. P., Bonet, M., Brizuela, V., Lissauer, D., Mohammad Iqbal Aman, Noormal, B., Espinoza, M., Pasquale, J., Leroy, C., Roelens, K., Vandenberghe, G., Urlyss Agossou, M. C., Keke, S. G., ... Gülmezoglu, A. M. (2025). Early warning systems for identifying severe maternal outcomes: findings from the WHO global maternal sepsis study. *EClinicalMedicine*, 79. <https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102981>
- Djimeli, A. D. K., Ateudjieu, J., & Kenfack, B. (2025). Partograph Utilization During Labor Monitoring in Sub-Saharan Africa: A Systematic Review and Meta-Analysis. *International Journal of Maternal and Child Health and AIDS*, 14, e018. https://doi.org/10.25259/ijma_1_2025
- Fetal monitoring in labour NICE guideline. (2022). www.nice.org.uk/guidance/ng229
- Godfrey, M. R., Atukunda, E. C., Tumuhimbise, W., Farjardo, Y. F., & Byamugisha, J. (2025). Exploring potential opportunities and strategies of using the Labour Care Guide to improve labour monitoring and health outcomes among health care providers in Uganda: a qualitative study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12884-025-08449-4>
- Hofmeyr, G. J., Moreri-Ntshabele, B., Qureshi, Z., Memo, N., Hanson, S., Muller, E., & Singata-Madliki, M. (2024). Improving management of first and second stages of labour in low- and middle-income countries. In *Best Practice and Research: Clinical Obstetrics and Gynaecology* (Vol. 95). Bailliere Tindall Ltd. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2024.102517>
- Mohan, M., Ramawat, J., La Monica, G., Jayaram, P., Fattah, S. A., Learmont, J., Bryan, C., Zaoui, S., Pullattayil, A. K., Konje, J., & Lindow, S. (2021). Electronic intrapartum fetal monitoring: a systematic review of international clinical practice guidelines. *AJOG Global Reports*, 1(2). <https://doi.org/10.1016/j.xagr.2021.100008>
- Mugenyi, G. R., Byamugisha, J., Tumuhimbise, W., Atukunda, E., & Yarine, F. T. (2024a). Labour Care Guide implementation as a decision-making tool for monitoring labour among healthcare providers in Uganda: protocol for a mixed-methods study. *BMJ Open*, 14(4). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-079216>
- Mugenyi, G. R., Byamugisha, J., Tumuhimbise, W., Atukunda, E., & Yarine, F. T. (2024b). Labour Care Guide implementation as a decision-making tool for monitoring labour among healthcare providers in Uganda: protocol for a mixed-methods study. *BMJ Open*, 14(4). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-079216>
- Piron-Dumitrascu, M., Cretoiu, D., Varlas, V. N., & Suci, N. (2025). Fetal and

maternal surveillance in high-risk pregnancy: tools, timing, and trends. *Journal of Medicine and Life*, 18(8), 745–752. <https://doi.org/10.25122/jml-2025-0105>

- Singh, K., Pathan, M., & Shah, M. (2020). Intrapartum fetal monitoring by cardiotocography and its correlation with labour outcome. *International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology*, 9(12), 4937. <https://doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20205225>
- Sulistiawati, R., Aristia, E., & Fitriyani, M. (2024). PEMBERDAYAAN IBU HAMIL MELALUI EDUKASI TENTANG PEMANTAUAN PERSALINAN KALA I FASE LATEN SECARA MANDIRI (SELF MONITORING) DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SAIGON KOTA PONTIANAK (Vol. 2).
- Ubom, A. E., Nieto-Calvache, A. J., Malel, Z. J., & Nunes, I. (2025). FIGO position statement on the use of the WHO labor care guide versus the partograph. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 170(1), 25–27. <https://doi.org/10.1002/ijgo.70151>
- Vishnu Priya, K., Kori, S., Yaliwal, R. G., SR, M., Malapure, P., & Sangolli, L. (2026). A Comparative Observational Study on the WHO Labour Care Guide Versus the WHO Modified Partograph on Labour Outcome. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.102080>
- Wibowo, S. S., & Kusumawati, N. (2023). Efektivitas Pelatihan Asuhan Persalinan Normal terhadap Kelengkapan Pencatatan Rekam Medis Persalinan: Penelitian Kuasi Eksperimen. *Health Information: Jurnal Penelitian*, 15(2), 172–179. <https://doi.org/10.36990/hijp.v15i2.836>

H. Glosarium

CTG = Cardiotocografi

CHAPTER 4

PENCEGAHAN KOMPLIKASI PERSALINAN

Rahmi padlilah, SST., Bdn., M.Keb.

A. Pendahuluan

1. Latar belakang:

Persalinan adalah proses fisiologis yang dialami oleh setiap Wanita hamil, namun dalam kenyataannya tidak semua kelahiran berlangsung normal. Berbagai komplikasi bisa muncul secara tiba-tiba dan mengancam keselamatan ibu dan bayi.

Beberapa masalah seperti perdarahan postpartum, preeklampsia, infeksi, dan persalinan yang berlangsung lama tetap menjadi penyebab utama tingginya angka kematian maternitas di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), secara global sekitar 800 wanita meninggal setiap hari akibat komplikasi kehamilan dan persalinan yang dapat dicegah, dengan rasio kematian ibu mencapai sekitar 223 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Situasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kematian ibu masih berkaitan dengan upaya pencegahan dan intervensi awal yang kurang optimal. (WHO 2023) Di Indonesia, keadaan ini tetap menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik melalui Sensus Penduduk 2020, Angka Kematian Ibu (AKI) tercatat sebesar 189 per 100.000 kelahiran hidup, yang masih jauh dari target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di bawah 70 per 100.000 kelahiran hidup. Selain itu, data terkini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat sekitar 4.150 kasus kematian ibu di Indonesia, di mana sebagian besar disebabkan oleh komplikasi seperti hipertensi yang dipicu kehamilan, perdarahan, dan infeksi. (BPS 2020)

Pemerintah Indonesia menargetkan untuk menurunkan angka kematian ibu menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024; namun, pencapaian target ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, kualitas layanan yang tidak merata, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan antenatal. Selain itu, fenomena 'tiga keterlambatan' (keterlambatan mengenali tanda-tanda bahaya, keterlambatan pengambilan keputusan, dan keterlambatan akses ke layanan kesehatan) tetap menjadi faktor utama yang

berkontribusi terhadap tingginya angka kematian ibu. Sebagian besar komplikasi persalinan sebenarnya dapat dicegah melalui langkah-langkah pencegahan dini, terutama melalui perawatan antenatal (ANC) berkualitas tinggi. Pemeriksaan antenatal secara teratur memungkinkan tenaga kesehatan mendeteksi faktor risiko seperti anemia, hipertensi, dan pertumbuhan janin yang terhambat sebelum berkembang menjadi komplikasi serius. Selain itu, mendidik ibu hamil dan keluarganya mengenai tanda-tanda peringatan kehamilan juga sangat penting dalam mencegah keterlambatan pengobatan.

Angka Kematian Ibu (AKI) tetap menjadi indikator utama dalam menilai status kesehatan suatu negara. Meskipun telah terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angka kematian ibu di Indonesia masih tinggi dibandingkan dengan target pembangunan kesehatan global. Situasi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan komplikasi persalinan belum berfungsi secara optimal dan masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Usaha untuk mencegah komplikasi saat melahirkan merupakan langkah penting dalam menurunkan angka kematian ibu (AKI). Mencegah bisa dilakukan melalui perawatan antenatal yang berkualitas, deteksi dini faktor risiko, dan pengelolaan yang tepat selama proses persalinan. Program seperti inisiatif Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) juga merupakan strategi utama dalam meningkatkan kesiapan ibu dan keluarga untuk melahirkan (Suryani et al. , 2024). Sebagian besar komplikasi saat melahirkan sebenarnya bisa dicegah melalui langkah-langkah promotif dan preventif yang dilakukan sejak awal kehamilan.

Perawatan antenatal berkualitas (ANC) adalah langkah awal yang sangat penting dalam mendeteksi faktor risiko secara dini. Melalui pemeriksaan rutin, tenaga kesehatan dapat mengidentifikasi wanita hamil yang berisiko mengalami komplikasi dan memberikan intervensi yang sesuai sebelum persalinan dimulai. Selain itu, edukasi kepada ibu hamil dan keluarga mengenai tanda bahaya kehamilan dan persalinan juga memiliki peran penting dalam pencegahan komplikasi. Kurangnya pengetahuan sering kali menyebabkan keterlambatan dalam mengenali situasi darurat, yang berujung pada penundaan perawatan. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan ini dikenal sebagai 'tiga keterlambatan', yaitu: keterlambatan dalam mengenali tanda-tanda bahaya, keterlambatan dalam pengambilan keputusan, serta keterlambatan dalam mengakses layanan kesehatan. Pemerintah Indonesia telah menciptakan berbagai program untuk mengurangi risiko komplikasi saat melahirkan, salah satunya adalah Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan ibu, keluarga, dan

masyarakat dalam menghadapi persalinan melalui perencanaan yang matang, termasuk menentukan tempat bersalin, tenaga kesehatan, transportasi, dan donor darah potensial. Namun, pelaksanaan program ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti sumber daya yang terbatas dan partisipasi masyarakat yang rendah. Pada saat persalinan, keberadaan tenaga kesehatan yang kompeten sangat penting untuk mencegah komplikasi dengan sukses. Pemantauan proses persalinan menggunakan alat seperti partograf memungkinkan deteksi awal terhadap penyimpangan dalam proses persalinan. Selain itu, penerapan manajemen aktif tahap ketiga persalinan telah terbukti efektif dalam mencegah perdarahan pascapersalinan, yang merupakan salah satu penyebab utama kematian maternal. Sebaliknya, sistem rujukan yang cepat dan tepat juga merupakan faktor kunci dalam mengelola komplikasi. Keterlambatan dalam proses rujukan sering kali menyebabkan kondisi ibu semakin memburuk. Dengan kurangnya pengetahuan seringkali menyebabkan keterlambatan dalam mengenali kondisi darurat, sehingga penanganan menjadi terlambat. Faktor keterlambatan ini dikenal dengan konsep “tiga terlambat” (three delays), yaitu terlambat mengenali tanda bahaya, terlambat mengambil keputusan, dan terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program untuk menurunkan risiko komplikasi persalinan, salah satunya adalah Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Program ini bertujuan meningkatkan kesiapan ibu, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi persalinan melalui perencanaan yang matang, termasuk penentuan tempat persalinan, tenaga kesehatan, transportasi, dan calon donor darah. Namun demikian, implementasi program ini di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan rendahnya partisipasi masyarakat. Pada saat persalinan, keberadaan tenaga kesehatan yang kompeten sangat menentukan keberhasilan dalam mencegah komplikasi. Pemantauan persalinan menggunakan alat seperti partograf memungkinkan deteksi dini terhadap penyimpangan proses persalinan. Selain itu, penerapan manajemen aktif kala III terbukti efektif dalam mencegah perdarahan postpartum sebagai salah satu penyebab utama kematian ibu.

Di sisi lain, sistem rujukan yang cepat dan efektif juga merupakan faktor penting dalam mengelola komplikasi. Keterlambatan dalam proses rujukan sering kali mengakibatkan penurunan kondisi ibu yang lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan sistem kesehatan yang terpadu, mulai dari layanan kesehatan primer hingga fasilitas rujukan spesialis.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencegahan komplikasi persalinan memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mencakup dari kehamilan, saat persalinan, hingga periode pasca melahirkan. Upaya ini melibatkan tidak hanya tenaga kesehatan, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif dari keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, penting untuk melakukan tinjauan yang lebih mendalam terhadap strategi pencegahan komplikasi persalinan agar dapat meningkatkan keselamatan ibu dan bayi serta menurunkan angka kematian maternal.

2. Pentingnya upaya preventif dan deteksi dini

Langkah-langkah pencegahan dan deteksi dini adalah faktor penting dalam mengurangi kemungkinan terjadinya komplikasi saat melahirkan yang dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Melalui pendekatan pencegahan, berbagai faktor risiko seperti anemia, hipertensi akibat kehamilan, dan pembatasan pertumbuhan janin dapat dikenali dan ditangani sejak awal, sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih parah. Deteksi dini yang dilakukan melalui pemeriksaan antenatal rutin memungkinkan tenaga medis untuk segera mengenali tanda-tanda peringatan dan memberikan intervensi yang tepat waktu. Selain itu, memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang gejala komplikasi sangat penting untuk memastikan bahwa ibu dan keluarganya dapat mengambil keputusan cepat jika terjadi keadaan darurat. Dengan demikian, kombinasi antara pencegahan dan deteksi dini tidak hanya mengurangi angka komplikasi, tetapi juga meningkatkan peluang keselamatan bagi ibu dan bayi selama proses persalinan. Tindakan pencegahan yang dilakukan secepat mungkin sangat penting untuk menghindari komplikasi saat melahirkan, karena sebagian besar masalah terkait kehamilan berkembang secara bertahap dan sering kali tidak menunjukkan gejala yang jelas di tahap awal. Jika faktor risiko seperti anemia, malnutrisi, atau hipertensi tidak terdeteksi sejak dini, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi komplikasi serius seperti perdarahan pasca-persalinan atau preeklampsia, yang dapat mengancam nyawa ibu dan bayi. Oleh karena itu, pencegahan harus dimulai sejak awal kehamilan, atau bahkan sebelum kehamilan terjadi. Selain itu, upaya preventif sedini mungkin juga penting untuk meningkatkan kesiapan ibu dalam menghadapi proses persalinan. Melalui edukasi dan pemantauan rutin, ibu hamil dapat memahami kondisi tubuhnya, mengenali tanda bahaya, serta mempersiapkan persalinan dengan lebih baik, baik dari segi fisik maupun mental. Kesiapan ini akan mengurangi risiko keterlambatan dalam pengambilan keputusan ketika

terjadi keadaan darurat, yang sering menjadi salah satu penyebab utama kematian ibu. (Ramadani, F. N., et al. 2025)

Selain itu, pencegahan dini memiliki peranan penting dalam memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan. Dengan deteksi lebih awal, para tenaga medis dapat mengelompokkan wanita hamil berdasarkan tingkat risiko mereka, sehingga perawatan yang sesuai dapat direncanakan, termasuk rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih cocok jika diperlukan. Hal ini membantu menghindari munculnya situasi darurat yang tidak dapat ditangani dengan baik di fasilitas kesehatan primer.

Dengan demikian, upaya pencegahan yang dilakukan seawal mungkin tidak hanya berfungsi untuk menghindari komplikasi tetapi juga menjadi strategi utama dalam meningkatkan kesehatan secara keseluruhan bagi ibu dan bayi, serta menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

3. Tujuan pencegahan komplikasi

Secara umum, upaya mencegah komplikasi kelahiran bertujuan untuk meningkatkan keselamatan ibu serta bayi selama masa kehamilan, proses melahirkan, dan periode setelah melahirkan. Tujuan-tujuan ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

a. Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Bayi

Langkah-langkah pencegahan bertujuan untuk menurunkan kemungkinan kematian akibat komplikasi seperti perdarahan, pre-eklampsia, dan infeksi. Melalui deteksi dini dan penanganan yang tepat, kondisi yang bisa mengancam jiwa dapat dihindari sejak tahap awal (Roslina et al. , 2024).

b. Mencegah Terjadinya Komplikasi Sejak Dini

Langkah-langkah pencegahan diambil untuk menemukan dan mengatasi faktor-faktor risiko sebelum berpotensi menjadi komplikasi serius. Hal ini mencakup pemantauan kesehatan ibu secara rutin dan penanganan dini untuk segala masalah yang terdeteksi. (Pattipeilohy et al. , 2023).

c. Meningkatkan Kesehatan Ibu Selama Kehamilan dan Persalinan

Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bahwa ibu tetap dalam kondisi terbaik, baik secara fisik maupun mental, agar ia mampu melewati proses persalinan dengan aman dan lancar (Achmad dan Hermanses, 2025).

d. Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Bayi

Pencegahan komplikasi juga menekankan pada kesejahteraan janin, seperti menghindari asfiksia, kelahiran prematur, dan berat badan lahir rendah dengan cara memantau pertumbuhan serta perkembangan janin. (Suryani et al. , 2024).

e. Meningkatkan Deteksi Dini Faktor Risiko

Dengan pemeriksaan rutin antenatal care (ANC), tenaga kesehatan dapat mengenali wanita hamil yang berisiko tinggi sehingga pengelolaan atau rujukan yang sesuai dapat dilakukan. (Mangampe dan Hidayat, 2024).

f. Meningkatkan Kesiapan Ibu dan Keluarga dalam Menghadapi Persalinan

Tujuan dari pencegahan adalah untuk memastikan bahwa para ibu dan keluarganya memiliki rencana yang matang untuk melahirkan, seperti memilih lokasi persalinan, tenaga medis, sarana transportasi, dan biaya yang dibutuhkan. (Qudriani et al. , 2025)

g. Mengurangi Keterlambatan Penanganan (Three Delays)

Pencegahan berfungsi untuk menangani:

- 1) Keterlambatan dalam mengidentifikasi tanda-tanda peringatan
- 2) Keterlambatan dalam mengambil keputusan
- 3) Keterlambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan

h. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan

Langkah-langkah pencegahan mendorong tenaga kesehatan untuk memberikan layanan yang sesuai dengan standar, termasuk pengawasan proses persalinan dan penanganan komplikasi yang tepat. (Roslina et al. , 2024).

i. Memperkuat Sistem Rujukan

Dengan deteksi yang awal, wanita hamil yang berisiko dapat segera dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, sehingga komplikasi dapat ditangani dengan baik.

j. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dan Keluarga

Pencegahan bertujuan untuk melibatkan keluarga dan masyarakat dalam mendukung kesehatan ibu, termasuk dalam pengambilan keputusan dan persiapan menjelang melahirkan

B. Konsep Dasar Komplikasi Persalinan

1. Definisi

Komplikasi saat melahirkan adalah kondisi medis yang muncul selama proses persalinan dan dapat membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Komplikasi ini bisa muncul tiba-tiba atau akibat dari kondisi berisiko tinggi selama masa kehamilan. Sebagian besar komplikasi saat melahirkan sebenarnya dapat dicegah melalui deteksi dini dan penanganan yang tepat (Roslina et al. , 2024).

2. Jenis komplikasi

a. Perdarahan postpartum

Pendarahan pascapersalinan (PPH) adalah kondisi yang ditandai dengan kehilangan darah yang berlebihan setelah melahirkan. Menurut definisi WHO (2023), PPH terjadi ketika kehilangan darah melebihi 500 ml setelah persalinan normal atau 1000 ml setelah operasi caesar, dalam 24 jam pertama setelah melahirkan. PPH merupakan salah satu komplikasi yang paling sering terjadi saat melahirkan yang dapat menyebabkan kematian ibu, terutama di negara-negara berkembang,

karena bisa dengan cepat berubah menjadi keadaan darurat Medis jika tidak ditangani Dengan segera.

Penyebab PPH dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori utama yang dikenal sebagai "4 Ts": (1) Tonus (Atonia Uterus): Otot rahim tidak berkontraksi dengan baik setelah plasenta dilahirkan. (2) Jaringan (Jaringan Tertinggal): Sisa-sisa plasenta atau membran yang tidak sepenuhnya keluar. (3) Trauma: Luka pada salura kelahiran, serviks, vagina, atau perineum.

(4) Thrombin (Gangguan Koagulasi): Masalah pembekuan darah atau gangguan koagulasi pada ibu. Pencegahan dan deteksi dini PPH sangat penting karena perdarahan yang tidak terkontrol Dapat Mengakibatkan syok,kegagalan organ,

bahkan kematian. Langkah-langkah pencegahan meliputi manajemen aktif dari tahap ketiga persalinan, pemberian obat uterotonik, dan pemantauan ketat terhadap ibu setelah melahirkan (Achmad dan Hermanses, 2025; WHO, 2023).

b. Preeklamsia/eklamsia

Preeklamsia adalah gangguan hipertensi yang khusus terjadi selama kehamilan, muncul setelah usia kehamilan 20 minggu, dan ditandai dengan tekanan darah tinggi yang baru muncul ($\geq 140/90$ mmHg) pada wanita yang sebelumnya memiliki tekanan darah normal, disertai dengan tanda-tanda kerusakan organ atau proteinuria. ACOG menyatakan bahwa meskipun sering disertai proteinuria, preeklamsia juga bisa didiagnosis tanpa proteinuria jika ada bukti disfungsi organ seperti kerusakan ginjal, trombositopenia, disfungsi hati, edema paru, atau gejala neurologis (misalnya, sakit kepala berat atau gangguan penglihatan). Diagnosis ini membantu tenaga medis untuk mengenali kondisi yang memiliki risiko tinggi terhadap morbiditas dan mortalitas maternal sejak awal. (ACOG 2020). Eklamsia merupakan komplikasi berat dari preeklamsia, ditandai dengan munculnya satu atau lebih kejang tonik-klonik umum pada seorang wanita hamil, tanpa sebab lain

selain hipertensi terkait kehamilan. Kejang-kejang ini terjadi di tengah preeklampsia yang tidak diobati dan merupakan keadaan darurat obstetri. Eklampsia menunjukkan perkembangan penyakit yang serius dan secara signifikan meningkatkan risiko kematian maternal dan neonatal jika tidak ditangani dengan segera. Eklampsia adalah komplikasi berat dari preeklampsia, ditandai dengan terjadinya satu atau lebih kejang tonik-klonik umum pada seorang wanita hamil, tanpa sebab lain selain hipertensi yang berhubungan dengan kehamilan. Kejang-kejang ini terjadi dalam konteks preeklampsia yang tidak diobati.

c. Infeksi

Infeksi yang berkaitan dengan persalinan adalah infeksi yang terjadi selama proses persalinan atau pada masa postpartum, yang mungkin melibatkan rahim, vagina, leher rahim, atau cedera yang terjadi saat melahirkan (misalnya, robekan perineum atau sayatan bedah caesar). Infeksi ini bisa berkisar dari ringan hingga parah dan dapat menyebabkan sepsis pada ibu, infeksi pada bayi baru lahir, atau bahkan kematian ibu dan bayi (Organisasi Kesehatan Dunia, 2022).

Jenis-jenis Infeksi Persalinan : (a) Endometritis: Infeksi pada lapisan dalam rahim (endometrium) setelah melahirkan, lebih umum terjadi pada persalinan bedah caesar. (b) Infeksi Saluran Kemih: Bisa muncul akibat kateterisasi atau factor Risiko lainnya Selama persalinan. (c) Infeksi Luka: Misalnya, pada area episiotomi Atau Robekan perineum. (d) Sepsis Neonatal: Infeksi yang ditularkan dari ibu ke bayi selama proses persalinan, terutama jika ada bakteri seperti Streptococcus Grup B. **Faktor Risiko :** (a) Proses persalinan yang berlangsung lama atau pengiriman yang berlarut-larut. (b) Pecahnya ketuban lebih dari 18 jam sebelum kelahiran. (c) Persalinan yang melibatkan intervensi (forsep, ekstraksi vakuum, atau bedahcaesar). (d) Kebersihan tenaga kesehatan dan lingkungan yang tidak memadai. (e) Status imun ibu yang lemah (misalnya, anemia,malnutrisi). **Dampak Infeksi Persalinan** Infeksi yang terjadi saat persalinan dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, termasuk: (a) Demam Tinggi Dan sepsis pada ibu. (b) Kematian ibu akibat sepsis atau syok septik.(c) Infeksi pada bayi baru lahir seperti pneumonia, meningitis, atau sepsis. (d) Masa tinggal yang lama di rumah sakit dan biaya perawatan yang tinggi.

d. Partus lama (Prolonged Labor)

Fase pembukaan yang berkepanjangan adalah fase pembukaan yang berlangsung lebih lama dari biasanya. Menurut WHO, fase pembukaan dianggap berkepanjangan jika fase aktif—from pelebaran serviks 4 cm hingga

10 cm—melebihi 12 jam pada wanita primipara dan 10 jam pada wanita multipara. Keadaan ini dapat mengakibatkan risiko kelelahan pada ibu, infeksi, perdarahan pasca persalinan, dan gangguan perfusi janin (Roslina et al. , 2024; Mangampe dan Hidayat, 2024). **Fase pembukaan** Berkepanjangan: (1) Kontraksi uterus yang lemah atau tidak efektif. (2) Presentasi atau posisi janin yang tidak normal. (3) Faktor psikologis, seperti stres dan kecemasan pada ibu. (4) Abnormalitas anatomi pada panggul ibu. **Komplikasi yang dapat ditimbulkan:** (1) Risiko infeksi yang lebih tinggi baik bagi ibu maupun neonatus. (2) Risiko trauma pada saluran persalinan yang meningkat. (3) Risiko hipoksia janin dan distress janin. **Penanganan:** (1) Pemantauan yang cermat dengan menggunakan partograf. (2) Induksi persalinan dengan oksitosin jika diperlukan. (3) Intervensi obstetrik seperti ekstraksi vakum, penjepit, atau operasi caesar jika persalinan tidak menunjukkan kemajuan.

e. Distosia (Difficult Labor / Obstructed Labor)

Pengertian:

Dystocia merupakan komplikasi dalam proses melahirkan yang disebabkan oleh ketidakcocokan antara ukuran janin dan pelvis ibu, atau posisi janin yang tidak normal. Dystocia termasuk salah satu penyebab utama kematian ibu dan bayi di negara-negara berkembang (Achmad dan Hermanses, 2025; WHO, 2023). Jenis-jenis Dystocia: Dystocia pelvis: Pelvis ibu terlalu sempit atau memiliki kelainan. (1) Dystocia janin: Posisi atau presentasi janin tidak normal (misalnya, bokong, melintang). (2) Dystocia gabungan: Kombinasi faktor dari ibu dan janin.

Dampak:

(1) Cedera pada saluran lahir ibu (robekan serviks atau perineum, atau episiotomi yang luas). (2) Asfiksia janin, cedera pada kepala atau bahu bayi. (3) Risiko perdarahan pasca melahirkan yang lebih tinggi. **Penanganan:** (1) Pengidentifikasian faktor risiko sejak periode antenatal (misalnya, pelvis sempit, ukuran janin yang besar). (2) Pemantauan aktif saat persalinan dengan menggunakan partograf. (3) Intervensi obstetri: operasi caesar jika terjadi persalinan terhalang, atau penggunaan alat hisap/picil untuk melahirkan jika diperlukan.

3. Faktor risiko

a. Faktor ibu:

Usia ibu merupakan salah satu determinan penting risiko persalinan. Ibu yang terlalu muda (<20 tahun) atau terlalu tua (>35 tahun) memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi persalinan. Ibu remaja (<20 tahun): Sistem

reproduksi belum matang sepenuhnya, sehingga lebih rentan mengalami partus lama, distosia, perdarahan postpartum, dan preeklamsia. Risiko bayi lahir prematur, berat badan lahir rendah (BBLR), dan mortalitas neonatal meningkat (Pattipeilohy et al., 2023; WHO, 2022). Ibu usia lanjut (>35 tahun): Risiko hipertensi, diabetes gestasional, preeklamsia, dan komplikasi kardiovaskular meningkat. Persalinan lebih mungkin memerlukan intervensi obstetri seperti sesar atau induksi persalinan (Roslina et al., 2024).

b. Paritas.

Paritas mengacu pada jumlah kehamilan yang telah dilahirkan oleh seorang ibu. Baik primipara (kelahiran pertama) maupun multipara (lebih dari satu kelahiran) memiliki risiko spesifik: Primipara (1 kali persalinan): (a) Risiko partus lama atau distosia lebih tinggi karena panggul dan jaringan jalan lahir belum pernah melewati proses persalinan. (b) Risiko robekan jalan lahir dan perdarahan postpartum meningkat (Achmad & Hermanses, 2025). Multipara tinggi (>4 kelahiran): (a) Otot uterus dan jalan lahir cenderung menurun tonus dan elastisitasnya, sehingga meningkatkan risiko atonia uteri dan perdarahan postpartum. (b) Risiko prolaps uterus dan komplikasi plasenta seperti plasenta previa juga meningkat (Mangampe & Hidayat, 2024).

c. status gizi

Status gizi ibu sebelum dan selama kehamilan memiliki pengaruh langsung terhadap risiko persalinan: Malnutrisi atau kekurangan energi kronis: Ibu kekurangan gizi (KEK) berisiko mengalami persalinan lama, distosia, anemia, dan infeksi. Bayi berisiko lahir BBLR dan prematur (WHO, 2022; Pattipeilohy et al., 2023). Obesitas atau overweight: Risiko hipertensi, preeklamsia, diabetes gestasional meningkat. Persalinan lebih mungkin memerlukan induksi atau operasi sesar. Pencegahan: (a) Konseling nutrisi selama antenatal care (ANC). (b) Pemantauan berat badan dan status gizi ibu. (c) Intervensi khusus untuk ibu remaja atau multipara tinggi.

d. Faktor pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang memadai adalah salah satu determinan utama keselamatan ibu dan bayi selama persalinan. Faktor pelayanan kesehatan mempengaruhi deteksi dini komplikasi, intervensi yang tepat, dan outcome maternal serta neonatal. (a) Faktor Akses ke Fasilitas Kesehatan (1) Ibu yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan atau memiliki keterbatasan transportasi berisiko mengalami terlambatnya penanganan komplikasi persalinan, termasuk perdarahan postpartum, eklamsi, dan distosia. (2) Konsep "Three Delays" menjelaskan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan akses pelayanan sebagai penyebab utama kematian maternal

(Mangampe & Hidayat, 2024; WHO, 2023). (b) Faktor Kualitas Antenatal Care (ANC) (1) ANC berkualitas memungkinkan deteksi dini faktor risiko seperti hipertensi, anemia, malposisi janin, atau plasenta previa. (2) Kekurangan ANC atau ANC yang tidak rutin meningkatkan kemungkinan komplikasi persalinan yang tidak terdeteksi, termasuk preeklamsi, infeksi, dan partus lama (Roslina et al., 2024; Pattipeilohy et al., 2023). (c) Faktor Ketersediaan Tenaga Kesehatan Terlatih (1) Kekurangan bidan, dokter, atau tenaga medis terlatih dapat menyebabkan penanganan persalinan yang tidak optimal, termasuk penatalaksanaan perdarahan, distosia, dan resusitasi neonatal. (2) Tenaga kesehatan yang terlatih dapat mengurangi risiko kematian maternal hingga 50% melalui intervensi tepat waktu (WHO, 2022). (d) Ketersediaan Sarana dan Peralatan Medis (1) Kurangnya obat-obatan (misal uterotonik), alat persalinan, atau fasilitas operasi sesar dapat meningkatkan risiko komplikasi serius. (2) Lingkungan persalinan yang tidak bersih juga meningkatkan risiko infeksi maternal dan neonatal (Mangampe & Hidayat, 2024). (e) Sistem Rujukan dan Manajemen Darurat (1) Sistem rujukan yang lambat atau tidak jelas dapat memperburuk outcome persalinan dengan komplikasi tinggi. (2) Implementasi protokol rujukan cepat dan transportasi darurat terbukti menurunkan angka kematian maternal (Qudriani et al., 2025).

e. Faktor sosial (akses, pendidikan)

Faktor Risiko Persalinan Berdasarkan Faktor Sosial

Faktor sosial mencakup kondisi lingkungan, pendidikan, ekonomi, dan dukungan keluarga yang memengaruhi kesehatan ibu selama kehamilan dan persalinan. Faktor sosial dapat meningkatkan risiko komplikasi persalinan apabila tidak diatasi dengan intervensi yang tepat. (a) Pendidikan Ibu, Ibu dengan pendidikan rendah cenderung memiliki pengetahuan terbatas mengenai tanda bahaya kehamilan dan persalinan, serta pentingnya ANC. (b) Kurangnya pengetahuan ini meningkatkan risiko terlambatnya pengambilan keputusan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sehingga komplikasi seperti perdarahan postpartum, eklamsi, atau infeksi dapat menjadi fatal (Roslina et al., 2024; Pattipeilohy et al., 2023). (c) Status Ekonomi, Ibu dengan status ekonomi rendah memiliki keterbatasan untuk akses ke fasilitas kesehatan berkualitas, transportasi, serta biaya persalinan. Kondisi ini dapat menyebabkan persalinan di rumah tanpa tenaga kesehatan terlatih, sehingga risiko komplikasi meningkat. (d) Dukungan Keluarga dan Lingkungan, Kurangnya dukungan keluarga dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan untuk rujukan ke fasilitas kesehatan saat terjadi komplikasi. Ibu hamil yang hidup sendiri atau dalam lingkungan sosial yang

terbatas lebih rentan terhadap stres, kurangnya nutrisi, dan keterlambatan penanganan komplikasi persalinan.

(e) Faktor Budaya, Praktik budaya tertentu dapat mempengaruhi cara ibu menerima perawatan kesehatan, misalnya persalinan di rumah atau kepercayaan terhadap pengobatan tradisional. Hal ini dapat meningkatkan risiko komplikasi yang seharusnya bisa dicegah melalui pelayanan medis (Mangampe & Hidayat, 2024; WHO, 2022).

4. Strategi Pencegahan Komplikasi Persalinan

Strategi pencegahan komplikasi persalinan adalah serangkaian upaya yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah persalinan untuk menurunkan risiko morbiditas dan mortalitas maternal serta neonatal. Tujuannya adalah memastikan persalinan aman bagi ibu dan bayi, mencegah komplikasi yang dapat terjadi, serta memungkinkan deteksi dan penanganan dini jika komplikasi muncul (Mangampe & Hidayat, 2024; WHO, 2023). Strategi ini meliputi pendekatan preventif, promotif, dan kuratif dini, yang melibatkan edukasi, intervensi medis, dan perbaikan sistem pelayanan kesehatan

a. Pencegahan Primer

1) Pencegahan Primer (Sebelum Persalinan)

- a) Kunjungan ANC rutin: Minimal 4–8 kali selama kehamilan untuk deteksi dini hipertensi, anemia, diabetes, malposisi janin, dan risiko infeksi.
- b) Nutrisi ibu: Konseling gizi, suplementasi zat besi, asam folat, dan peningkatan status gizi.
- c) Edukasi ibu dan keluarga: Mengenali tanda bahaya kehamilan, rencana persalinan, dan akses fasilitas kesehatan.
- d) Vaksinasi dan pencegahan infeksi: Misalnya imunisasi tetanus dan deteksi infeksi bakteri/virus (Roslina et al., 2024; WHO, 2022).

2) Pencegahan Selama Persalinan

- a) Manajemen aktif kala III: Pemberian uterotonik setelah plasenta lahir untuk mencegah perdarahan postpartum.
- b) Pemantauan persalinan dengan partograf: Untuk mendeteksi partus lama, distosia, atau tanda distress janin.
- c) Kebersihan dan asepsis: Sterilisasi alat persalinan dan lingkungan untuk mencegah infeksi maternal dan neonatal.
- d) Penanganan komplikasi dini: Intervensi tepat bila muncul distosia, perdarahan, atau tanda preeklamsi/eklamsi (Achmad & Hermanses, 2025).

3) Pencegahan Postpartum (Setelah Persalinan)

- a) Pemantauan ibu dan bayi: Deteksi dini perdarahan, infeksi, atau komplikasi lain dalam 24–48 jam pertama.
- b) Pendidikan ibu: Cara perawatan luka, nutrisi, tanda bahaya pascapersalinan, dan perawatan bayi.
- c) Rujukan cepat bila perlu: Ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut jika komplikasi terjadi.

4) Pendekatan Sistemik

- a) Pelatihan tenaga kesehatan: Meningkatkan keterampilan bidan, dokter, dan perawat dalam penatalaksanaan persalinan.
- b) Ketersediaan fasilitas dan obat-obatan: Misalnya uterotonik, antibiotik, alat resusitasi neonatal.
- c) Sistem rujukan yang efektif: Transportasi dan komunikasi untuk kasus gawat darurat maternal.
- d) Monitoring dan evaluasi program kesehatan maternal: Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menurunkan angka kematian ibu (Qudriani et al., 2025; WHO, 2023).

5) Program P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi)

Program P4K adalah program nasional yang digagas oleh **Kementerian Kesehatan Indonesia** untuk **meningkatkan keselamatan ibu dan bayi** melalui **perencanaan persalinan yang matang dan pencegahan komplikasi persalinan**. P4K merupakan pendekatan **preventif dan promotif**, dengan tujuan menurunkan morbiditas dan mortalitas maternal dan neonatal.

Program ini menekankan **persiapan ibu, keluarga, dan fasilitas kesehatan** agar siap menghadapi persalinan dan kemungkinan komplikasi yang dapat terjadi. (1) Identifikasi Risiko Kehamilan Deteksi dini faktor risiko seperti usia ibu, paritas, riwayat komplikasi persalinan sebelumnya, hipertensi, diabetes gestasional, dan status gizi. (2) Perencanaan Persalinan Menentukan tempat persalinan yang aman, tenaga kesehatan yang menangani, rencana transportasi, dan persiapan dana jika perlu rujukan. (3) Kesiapan Menghadapi Komplikasi Menyiapkan kit persalinan bersih, mengetahui tanda bahaya persalinan (perdarahan, eklamsi, infeksi), dan prosedur rujukan cepat. (4) Edukasi dan Pendampingan Keluarga Meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga mengenai tanda bahaya, nutrisi, perawatan bayi, dan pentingnya ANC. (5) Monitoring dan Evaluasi Pencatatan dan pemantauan ibu hamil melalui posyandu, bidan desa, atau fasilitas kesehatan terdekat untuk memastikan implementasi program.

Manfaat Program P4K (1) Mengurangi risiko kematian maternal dan neonatal akibat komplikasi persalinan. (2) Membantu keluarga dan ibu hamil dalam menyiapkan persalinan aman. (3) Mempermudah deteksi dini komplikasi dan mempercepat rujukan ke fasilitas kesehatan. (4) Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan dengan tenaga profesional (Roslina et al., 2024; Mangampe & Hidayat, 2024).

b. Pencegahan Sekunder (Saat Persalinan)

1) Persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih (Bidan dan Dokter)

Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (seperti bidan, dokter, atau perawat) sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganan komplikasi bagi ibu maupun bayi. Tenaga terlatih memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memantau proses persalinan secara tepat, mengenali tanda bahaya sejak dini, serta mengambil tindakan yang cepat dan sesuai jika terjadi masalah. Dalam proses persalinan, berbagai komplikasi dapat muncul secara tiba-tiba, seperti perdarahan, infeksi, tekanan darah tinggi, atau kesulitan persalinan. Tanpa penanganan yang tepat, kondisi ini dapat berakibat fatal. Tenaga kesehatan terlatih mampu melakukan intervensi medis yang diperlukan, seperti pemberian obat, tindakan pertolongan persalinan, hingga rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap jika dibutuhkan. Selain itu, kehadiran tenaga terlatih juga berperan dalam menjaga kebersihan dan keamanan proses persalinan, sehingga mengurangi risiko infeksi pada ibu dan bayi. Mereka juga memberikan edukasi kepada ibu mengenai perawatan pasca persalinan, tanda bahaya, serta pentingnya menyusui dini. Dengan demikian, persalinan oleh tenaga terlatih merupakan langkah kunci dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta memastikan keselamatan dan kesehatan keduanya selama dan setelah proses persalinan. (Pattipeilohy, C. I., et al.2023)

2) Monitoring persalinan

Monitoring persalinan adalah proses pengawasan secara terus-menerus terhadap kondisi ibu dan janin selama proses persalinan untuk memastikan semuanya berjalan normal serta mendeteksi secara dini adanya komplikasi. Tujuan monitoring persalinan adalah: (a) Menilai kemajuan persalinan (apakah berjalan normal atau tidak) (b) Memantau kondisi kesehatan ibu dan janin (c) Mendeteksi tanda bahaya sejak dini (d) Menentukan tindakan yang tepat jika terjadi komplikasi. Manfaat monitoring persalinan: (a) Mencegah keterlambatan penanganan

komplikasi (b) Mengurangi risiko kematian ibu dan bayi (c) Membantu pengambilan keputusan klinis secara cepat dan tepat (d) Menjamin proses persalinan yang lebih aman. Secara keseluruhan, monitoring persalinan merupakan bagian penting dalam asuhan persalinan yang berkualitas, karena memungkinkan deteksi dini dan penanganan cepat terhadap berbagai risiko yang dapat terjadi selama persalinan. Salah satu alat penting dalam monitoring persalinan adalah partograf, yaitu grafik yang digunakan untuk mencatat kemajuan persalinan dan kondisi ibu serta janin secara sistematis. Dengan partograf, tenaga kesehatan dapat lebih mudah mengidentifikasi jika persalinan berjalan lambat atau terjadi penyimpangan dari kondisi normal. Aspek yang dimonitor dalam persalinan meliputi: (a) Kondisi ibu Tanda vital (tekanan darah, nadi, suhu, pernapasan), Kontraksi uterus (frekuensi, durasi, kekuatan), Kondisi umum (kesadaran, nyeri, kelelahan), Tanda komplikasi seperti perdarahan atau preeklamsia (b) Kondisi janin, Denyut jantung janin (DJJ) untuk menilai kesejahteraan janin, Pergerakan janin Warna air ketuban (jernih atau bercampur mekonium). (b) Kemajuan persalinan, Pembukaan serviks, Penurunan kepala janin, Posisi janin

3) Deteksi dini komplikasi

Deteksi dini komplikasi

- a) Preeklamsia sangat penting untuk mencegah kondisi yang lebih berat seperti eklamsia. Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam praktik kebidanan komunitas adalah metode ECOC (Education, Check-up Observation, dan Collaboration). (a) Education (Edukasi) Ibu hamil diberikan pemahaman mengenai: Tanda dan gejala preeklamsia (sakit kepala hebat, pandangan kabur, nyeri ulu hati, pembengkakan pada wajah dan tangan), Pentingnya pemeriksaan kehamilan rutin, Pola hidup sehat (istirahat cukup, nutrisi seimbang). Edukasi ini membantu ibu mengenali tanda bahaya sejak dini sehingga dapat segera mencari pertolongan. (b) Check-up (Pemeriksaan), Pemeriksaan rutin menjadi kunci deteksi dini, meliputi, Pengukuran tekanan darah (hipertensi adalah tanda utama preeklamsia), Pemeriksaan protein urin, Pemantauan berat badan dan edema, Evaluasi kondisi janin. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan dalam kunjungan antenatal care (ANC). (c) Observation (Observasi) Tenaga kesehatan melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap: Perkembangan gejala klinis, Perubahan tekanan darah, Kondisi ibu dan janin. Observasi penting untuk melihat apakah kondisi memburuk atau tetap stabil. (d)

Collaboration (Kolaborasi/Rujukan) Jika ditemukan tanda preeklamsia: Dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, Kolaborasi dengan dokter spesialis untuk penanganan lebih Dengan penerapan ECOC yang baik, penanganan preeklamsia dapat dilakukan lebih cepat, tepat, dan terkoordinasi.(ACOC 2024)

b) Fetal distress

Fetal distress atau gawat janin adalah kondisi di mana janin mengalami gangguan kesejahteraan, terutama akibat kekurangan oksigen (*hipoksia*) selama kehamilan atau persalinan. Saat ini, istilah yang lebih dianjurkan dalam praktik klinis adalah "non-reassuring fetal status", karena lebih menggambarkan kondisi janin berdasarkan hasil pemantauan. Tanda dan Gejala Fetal Distress (a) Perubahan Denyut Jantung Janin (DJJ) Ini merupakan indikator paling penting: Bradikardia: DJJ < 110 kali/menit, Takikardia: DJJ > 160 kali/menit (d) Variabilitas DJJ menurun atau tidak ada, Deselerasi lambat (*late deceleration*) atau variabel berat. (b) Penurunan Gerakan Janin Ibu merasakan gerakan janin berkurang atau tidak aktif, Menjadi tanda awal adanya gangguan oksigenasi. (c) Air Ketuban Bercampur Mekonium, Warna kehijauan atau keruh, Menandakan stres pada janin, terutama bila disertai gangguan DJJ. (d) Hasil Pemeriksaan Penunjang Abnormal, CTG (*cardiotocography*) menunjukkan pola non-reassuring, Profil biofisik janin rendah, pH darah janin menurun (asidosis). (e) Kondisi Ibu yang Berisiko, Preeklamsia, perdarahan, infeksi, Persalinan lama atau partus macet, Hipotensi atau hipoksia pada ibu.

c) Partus lama

Partus lama adalah persalinan yang berlangsung lebih lama dari batas normal akibat kemajuan persalinan yang lambat atau terhenti. Secara klinis Pada primigravida: persalinan > 24 jam, Pada multigravida: persalinan > 18 jam, Dalam praktik modern, definisi juga mengacu pada kemajuan persalinan yang tidak adekuat berdasarkan grafik seperti partograf (misalnya pembukaan serviks tidak bertambah sesuai waktu yang diharapkan). (a) Tanda dan Gejala Partus Lama, Kemajuan Persalinan Lambat, Pembukaan serviks berlangsung sangat lambat (<1 cm/jam pada fase aktif), Tidak ada kemajuan penurunan kepala janin. (b) Kontraksi Tidak Adekuat, Kontraksi lemah, jarang, atau tidak teratur, Durasi kontraksi pendek. Kelelahan pada Ibu, Ibu tampak lemah, kelelahan, dehidrasi, Nyeri berkepanjangan (c) Tanda Risiko pada Janin, Denyut jantung janin tidak normal (bisa mengarah ke fetal distress), Air

ketuban keruh atau bercampur mekonium. (d) Tanda Komplikasi pada Ibu, Dehidrasi, ketonuria, Infeksi (demam, takikardia), Risiko perdarahan meningkat.

- d) Faktor Penyebab (Tambahan Penting) Sering dikaitkan dengan konsep 3P: Power: kontraksi lemah, Passenger: ukuran/posisi janin tidak sesuai, Passage: panggul sempit atau hambatan jalan lahir (WHO 21021)

4) Pencegahan Tersier (Penanganan Komplikasi)

- a) Rujukan tepat waktu

Rujukan tepat waktu adalah proses pengalihan pasien dari fasilitas pelayanan kesehatan dengan kemampuan terbatas ke fasilitas yang lebih lengkap secara cepat, sesuai indikasi medis, dan tanpa penundaan, guna mendapatkan penanganan yang adekuat dan mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat.

Dalam konteks kesehatan ibu dan bayi, rujukan tepat waktu merupakan bagian penting dari sistem pelayanan obstetri yang terintegrasi, terutama pada kasus kegawatdaruratan seperti perdarahan, preeklamsia, partus lama, dan gawat janin.

Prinsip Rujukan Tepat Waktu Rujukan dikatakan tepat waktu apabila memenuhi: Cepat: dilakukan segera setelah ditemukan tanda bahaya Tepat indikasi: berdasarkan kondisi medis yang membutuhkan penanganan lanjutan tepat tujuan: dirujuk ke fasilitas yang memiliki kemampuan sesuai (PONED/PONEK) Tepat transportasi: menggunakan sarana yang aman dan memadai Tepat komunikasi: ada informasi awal ke fasilitas tujuan (rujukan terkoordinasi). Tujuan Rujukan Tepat Waktu, Mencegah keterlambatan penanganan (delay), Menurunkan angka kematian ibu dan bayi, Memastikan pasien mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan, Mengurangi risiko komplikasi lebih lanjut. Konsep Keterlambatan (Three Delays Model). Rujukan tepat waktu berkaitan erat dengan pencegahan tiga keterlambatan: Terlambat mengambil keputusan mencari pertolongan, Terlambat mencapai fasilitas Kesehatan, Terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan

- b) Sistem rujukan terintegrasi

Sistem rujukan terintegrasi adalah suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan pasien secara timbal balik antar fasilitas kesehatan (primer, sekunder, dan tersier) secara terkoordinasi, berjenjang, dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan medis pasien. United Nations Population Fund. (2022).

Sistem ini memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang tepat sesuai tingkat kemampuan fasilitas Kesehatan. (1) Tujuan Sistem Rujukan Terintegrasi, Menjamin akses pelayanan kesehatan yang optimal dan berkesinambungan. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Mengurangi angka kesakitan dan kematian, terutama pada ibu dan bayi Menghindari keterlambatan penanganan kasus kegawatdaruratan. (2) Komponen Sistem Rujukan Terintegrasi, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, (a) Tingkat pertama (primer): Puskesmas, klinik, bidan praktik mandiri, (b) Tingkat lanjutan (sekunder): (c) Rumah sakit tipe C/B, (d) Tingkat rujukan tertinggi (tersier): Rumah sakit tipe A dengan fasilitas spesialis lengkap. (3) Alur Rujukan, (a) Rujukan vertikal: dari fasilitas rendah ke lebih tinggi (misalnya Puskesmas ke RS) (b) Rujukan horizontal: antar fasilitas dengan tingkat yang sama (c) Rujuk balik: pasien dikembalikan ke fasilitas asal setelah kondisi stabil. (4) Sistem Komunikasi dan Informasi, Surat rujukan lengkap (diagnosis, tindakan, kondisi pasien) ,Komunikasi antar tenaga kesehatan (telepon, sistem digital), Sistem informasi rujukan (misalnya aplikasi rujukan online). (5) Transportasi Rujukan, Ambulans atau transportasi yang memadai, Dilengkapi alat dan tenaga kesehatan bila diperlukan. (6) Sumber Daya Manusia Tenaga kesehatan terlatih (bidan, dokter, perawat),Kemampuan mengenali indikasi rujukan dan stabilisasi awal. (7) Prinsip Sistem Rujukan Terintegrasi Keterpaduan: antar fasilitas saling terhubung, Kecepatan dan ketepatan: tidak ada penundaan, Kontinuitas pelayanan: pasien tetap dipantau ,Efisiensi: sesuai kebutuhan medis, tidak berlebihan, Keselamatan pasien: prioritas utama. World Bank. (2022).

c) Kolaborasi rujukan

Kolaborasi rujukan adalah kerja sama antara berbagai tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam proses rujukan pasien, yang melibatkan komunikasi, koordinasi, dan pembagian peran untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan berkesinambungan. Kolaborasi ini merupakan bagian dari interprofessional collaboration (IPC), yaitu praktik kerja sama antar profesi kesehatan yang berbeda untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. WHO. (2010–2023).

(1) Tujuan Kolaborasi Rujukan

Mempercepat proses rujukan pasien Meningkatkan kualitas dan keselamatan pelayanan (a) Mengurangi keterlambatan penanganan (delay) (b) Menjamin kesinambungan pelayanan pasien Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik dapat mempercepat waktu rujukan dan meningkatkan hasil klinis pasien. Handi, A. (2024).

(2) Komponen Kolaborasi Rujukan

(a) Komunikasi Efektif

- Pertukaran informasi antar tenaga kesehatan (bidan, dokter, perawat)
- Informasi meliputi diagnosis, kondisi pasien, dan tindakan yang telah dilakukan

(b) Koordinasi Antar Fasilitas

- Fasilitas pengirim dan penerima saling berkoordinasi
- Memastikan kesiapan fasilitas tujuan sebelum pasien dirujuk

(c) Pembagian Peran dan Tanggung Jawab

- Setiap tenaga kesehatan memiliki peran yang jelas

(d) Kerja Tim (Teamwork)

- Tenaga kesehatan bekerja secara saling bergantung
- Mengambil keputusan bersama demi keselamatan pasien

(e) Sistem Pendukung (Teknologi & Jejaring)

- Contoh: penggunaan sistem rujukan digital atau grup komunikasi
- Inovasi seperti jejaring rujukan maternal dapat meningkatkan koordinasi antar petugas. Amijaya, D.T. et al. (2024).

c. Model Kolaborasi dalam Rujukan

- 1) Konsultatif: tenaga kesehatan saling bertukar informasi
- 2) Koordinatif: bekerja bersama dengan pembagian tugas
- 3) Kolaboratif penuh: pengambilan keputusan dilakukan secara tim multidisiplin

d. Manfaat Kolaborasi Rujukan

- 1) Mempercepat penanganan kegawatdaruratan
- 2) Meningkatkan kepuasan pasien
- 3) Menurunkan angka komplikasi dan kematian
- 4) Meningkatkan efisiensi sistem kesehatan

Kolaborasi lintas profesi juga terbukti meningkatkan kualitas pelayanan dan hasil kesehatan pasien secara keseluruhan. Yuliyanti, S. (2021)

e. Tantangan dalam Kolaborasi Rujukan

- 1) Kurangnya komunikasi antar profesi
- 2) Perbedaan kewenangan atau hierarki
- 3) Keterbatasan sumber daya (SDM dan fasilitas)
- 4) Sistem informasi yang belum optimal

C. Referensi

- Achmad, I., & Hermanses, S. (2025). Observasi persalinan sebagai strategi pencegahan komplikasi. *Jurnal Kebidanan*.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). *Gestational Hypertension and Preeclampsia: ACOG Practice Bulletin No. 222*. Obstetrics & Gynecology
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2021). *Labor and Delivery Management Guidelines*.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2021). *Practice Bulletin: Fetal Heart Rate Monitoring*.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2024). *Eclampsia Algorithm*. Guideline Central.
- Amijaya, D.T. et al. (2024). *Jejaring Rujukan Maternal dan Neonatal*
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Angka Kematian Ibu (AKI) hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*.
- Handi, A. (2024). *The Impact of Interprofessional Collaboration on Referral Time*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2025). *Data kematian ibu di Indonesia tahun 2024*.
- Kementerian Kesehatan RI. (2025). *Review kebijakan penurunan angka kematian ibu*.
- Mangampe, N., & Hidayat, A. (2024). Pelaksanaan program pencegahan komplikasi persalinan. *Journal of Telenursing*.
- National Institute for Health and Care Excellence. (2022). *Intrapartum Care Guidelines*.
- Pattipeilohy, C. I., et al. (2023). Exploration of the birth planning and complications prevention program implementation. *Jurnal Kesehatan*.
- Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. (2016). *Panduan Nasional Pelayanan Kedokteran: Hipertensi dalam Kehamilan*.

- Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. (2020). *Panduan Pelayanan Obstetri*.
- Pinandia, R. P. (2025). Manajemen pencegahan komplikasi persalinan: Literature review. *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- Qudriani, M., et al. (2025). Optimalisasi kesehatan maternal dan bayi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Ramadani, F. N., et al. (2025). Edukasi kehamilan dan persalinan aman dengan program P4K. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Roslina, et al. (2024). Determinants of childbirth complications. *Jurnal Kesehatan*.
- Setiawati, E., et al. (2026). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan program P4K. *Scientific Journal*.
- Suryani, D., Hartono, B., & Asmarwiati, S. (2024). Analisis implementasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K). *Jurnal Kesehatan Tambusai*.
- United Nations Population Fund. (2022). *Maternal Health and Referral Systems Strengthening*.
- World Bank. (2022). *Improving Health Systems Efficiency and Referral Networks*.
- World Health Organization. (2010–2023). *Framework for Interprofessional Collaboration & Quality of Care*.
- World Health Organization. (2011). *WHO Recommendations for Prevention and Treatment of Pre-eclampsia and Eclampsia*.
- World Health Organization. (2018–2023). *Intrapartum Care for a Positive Childbirth Experience*.
- World Health Organization. (2022). *Strategies for improving maternal and neonatal health services*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2023). *Managing complications in pregnancy and childbirth: A guide for midwives and doctors*. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2023). *Maternal mortality*.
- Yuliyanti, S. (2021). *Kolaborasi Interprofesi pada Pelayanan Rujukan Maternal*.

PROFIL PENULIS



Syafliindawati, S.SiT, M.Keb. Lahir di Ps. Baru Laitan tanggal 29 Oktober 1969. Penulis menyelesaikan Pendidikan D III Keperawatan, Tahun 1993, mengikuti Program Pendidikan D III Kebidanan th 2006 selanjutnya tahun 2007 menyelesaikan pendidikan D IV Bidan Pendidik di Poltekes Kemenkes Padang. Tahun 2015 menyelesaikan Pendidikan di Pascasarjana Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, jurusan Program Studi Kebidanan dengan gelar Magister Kebidanan (M.Keb).

Riwayat Pekerjaan: Pada tahun 1993 awal penulis mulai bekerja sebagai pengajar di STIKes Ranah Minang Padang sebagai Dosen Kebidanan. Tahun 2013 s/d 2017 sebagai Ketua Program Studi D IV Bidan Pendidik, tahun 2017 diberi amanah menjadi Wakil Ketua II di STIKES Ranah Minang Padang. Membimbing mahasiswa praktikum di laboratorium maupun di lapangan merupakan tugas utama Penulis yang juga salah seorang pengurus aktif di organisasi profesi IBI Ranting dari tahun 2019 sampai saat ini. Sejak tahun 2019, penulis aktif sebagai dosen di Program Studi S1 Kebidanan Institut Citra Internasional Bangka Belitung. **Riwayat Mengajar :** Pengampu pada Mata Kuliah Profesionalisme Kebidanan, Etika dan Hukum Kesehatan, Psikologi Praktik Kebidanan , Praktik Kebidanan, Kebijakan dalam pelayanan kebidanan dan Evidence based Midwifery (EBM). Dan sudah beberapa kali publish penelitian dan mendapatkan Hki modul maupun buku ajar yang ber ISSN untuk mahasiswa kebidanan.

Motto : Disiplin adalah Kunci Kesuksesan, dan Rasa Syukur adalah Kunci Kebahagiaan.

PROFIL PENULIS



Ernita Prima Noviyani, S.ST.,Bdn.,M.Kes

Lahir di Jakarta, 11 November 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Diplova IV Kebidanan, Universitas Indonesia Maju tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Indonesia Maju dan lulus pada tahun 2013. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 bekerja di praktik mandiri bidan, kemudian mulai tahun 2012 bekerja di Universitas Indonesia Maju. Tahun 2020-sekarang mengelola Praktik Mandiri bidan, sehingga teori yang disampaikan juga diaplikasikan langsung ke klien/masyarakat. Saat ini penulis bekerja di Universitas Indonesia Maju mengampu mata kuliah kehamilan, persalinan dan bayi baru lahir, intervensi kesehatan reproduksi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, terapis spa ibu dan bayi, fasilitator yoga, *child birth educator* & doula. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ernitaprima.stikim@gmail.com

Motto: "*Pengetahuan yang baik adalah yang memberi manfaat, bukan yang hanya diingat*" (Imam Al-Syafi'i)

PROFIL PENULIS



Sulastri Handayani, S.Tr.Keb., Bdn., M.Keb Lahir di Alas, 28 Desember 1997. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan, Universitas Aisyiyah Yogyakarta tahun 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan Profesi Bidan di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2021. Kemudian melanjutkan S2 pada Universitas Hasanuddin dan lulus pada tahun 2025. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2021 sebagai seorang praktisi di salah satu klinik di Yogyakarta. Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Banten mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan kesehatan reproduksi. Dan saat ini penulis juga bekerja di salah satu Rumah Sakit Arab Saudi tepatnya di Hayat National Hospital. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: sulastri34h56@gmail.com
Motto: "Be better every day"



Rahmi Padlilah, SST., Bdn., M.Keb. Lahir di Kalsel , 02 Juni 1971. Pendidikan D3 Kebidanan Poltekkes Bandung thn 2006, D4 Kebidanan Universitas Padjajaran Bandung thn 2014, S2 Universitas Padjajaran Bandung thn 2017. Praktisi pelayanan Kebidanan Mom and Me, Trainer kegawatdaruratan BHTC dan 118, aktif di beberapa Organisasi Pemerintah, Organisasi Profesi dan organisasi sosial, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Ketua Perkumpulan pembina olah raga Indonesia Provinsi Kalimantan Utara. Saat ini penulis bekerja di Universitas Borneo Tarakan sebagai dosen mengampu mata Profesionalisme Kebidanan, Asuhan Persalinan Normal dan Kegawatdaruratan Maternal Perinatal Aktif kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, Narasumber dan trainer. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: rahmipadlilah@gmail.com
Motto: "Enjoy for your life "

Sinopsis

Bunga Rampai **“Pendampingan Persalinan Aman dan Berpusat pada Perempuan”** membahas konsep dan praktik pendampingan persalinan yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, serta penghormatan terhadap martabat perempuan. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar persalinan normal dan aman, meliputi pengertian persalinan yang aman, proses persalinan normal yang berpusat pada perempuan, prinsip persalinan aman, serta konsep *Respectful Maternity Care*. Pembahasan juga menyoroti tindakan dan pemeriksaan yang tidak direkomendasikan pada kala II, sehingga pembaca dapat memahami pentingnya pelayanan kebidanan yang berbasis bukti, tidak berlebihan, dan tetap menghargai hak serta kebutuhan ibu selama proses persalinan.

Selanjutnya, buku ini menguraikan pengkajian kebidanan selama proses persalinan sebagai dasar dalam menentukan kondisi ibu dan janin secara tepat. Materi yang dibahas mencakup konsep dasar pengkajian persalinan, komponen pengkajian kebidanan, pengkajian berdasarkan kala persalinan, identifikasi masalah dan diagnosis kebidanan, dokumentasi pengkajian, serta peran bidan dalam proses pengkajian. Melalui pembahasan ini, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa pengkajian yang sistematis, akurat, dan berkesinambungan sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan klinis serta menjamin keselamatan ibu dan bayi.

Pada bagian berikutnya, buku ini membahas pemantauan kemajuan persalinan dan kesejahteraan ibu-janin, termasuk parameter pemantauan, penggunaan partograf, serta deteksi dini komplikasi yang dapat terjadi selama persalinan. Buku ini juga memuat pembahasan mengenai pencegahan komplikasi persalinan sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Dengan penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, tenaga kesehatan, serta pembaca yang ingin memahami pendampingan persalinan aman, nyaman, profesional, dan berpusat pada perempuan.



Bunga Rampai “Pendampingan Persalinan Aman dan Berpusat pada Perempuan” membahas konsep dan praktik pendampingan persalinan yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan, serta penghormatan terhadap martabat perempuan. Buku ini diawali dengan pembahasan mengenai konsep dasar persalinan normal dan aman, meliputi pengertian persalinan yang aman, proses persalinan normal yang berpusat pada perempuan, prinsip persalinan aman, serta konsep Respectful Maternity Care. Pembahasan juga menyoroti tindakan dan pemeriksaan yang tidak direkomendasikan pada kala II, sehingga pembaca dapat memahami pentingnya pelayanan kebidanan yang berbasis bukti, tidak berlebihan, dan tetap menghargai hak serta kebutuhan ibu selama proses persalinan.

Selanjutnya, buku ini menguraikan pengkajian kebidanan selama proses persalinan sebagai dasar dalam menentukan kondisi ibu dan janin secara tepat. Materi yang dibahas mencakup konsep dasar pengkajian persalinan, komponen pengkajian kebidanan, pengkajian berdasarkan kala persalinan, identifikasi masalah dan diagnosis kebidanan, dokumentasi pengkajian, serta peran bidan dalam proses pengkajian. Melalui pembahasan ini, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa pengkajian yang sistematis, akurat, dan berkesinambungan sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan klinis serta menjamin keselamatan ibu dan bayi.

Pada bagian berikutnya, buku ini membahas pemantauan kemajuan persalinan dan kesejahteraan ibu-janin, termasuk parameter pemantauan, penggunaan partograf, serta deteksi dini komplikasi yang dapat terjadi selama persalinan. Buku ini juga memuat pembahasan mengenai pencegahan komplikasi persalinan sebagai bagian penting dari upaya meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. Dengan penyajian yang sistematis dan aplikatif, buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa kebidanan, dosen, bidan, tenaga kesehatan, serta pembaca yang ingin memahami pendampingan persalinan aman, nyaman, profesional, dan berpusat pada perempuan.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-36-7 (PDF)



9

786347

756367